UE B2 · SEMESTRE 1

PSYCHOPATHOLOGIE

Fiche de révision écrite

Cours de Nathalie Khatir · Support officiel 2026 et explications de cours

Comprendre les troubles et la relation de soin

Relier les manifestations cliniques au vécu singulier, comparer les approches et maîtriser les notions du support, avec leurs définitions développées.

Objectifs de révision

Normal et pathologique ; lectures du symptôme ; métapsychologie ; angoisses et défenses ; sémiologie et classifications.

Deux niveaux de lecture

Comprendre les explications puis mémoriser les définitions. Les modèles théoriques et les catégories historiques sont identifiés dans leur contexte.

Une démarche pour lire une situation

Étape	Question à se poser
Décrire	Que dit la personne ? Qu'observe-t-on et depuis quand ?
Comprendre	Quel vécu, quel contexte et quelle lecture théorique ?
Relier	Quels liens entre manifestations, retentissement et ressources ?

Sommaire rapide — accès direct aux chapitres

Champ et normalité · p. 2
Variabilité et causes · p. 3
Approches et apprentissages · p. 4
Psychanalyse et inconscient · p. 5
Pulsions et topiques · p. 6
Économie et dynamique · p. 8
Développement · p. 9
Angoisses et structure · p. 10
Défenses et transfert · p. 12
Sémiologie et classifications · p. 13
Épisode dépressif · p. 14
Pièges et synthèse · p. 16
Définitions et mots-clés · p. 18

Repère de mémorisation

Apprendre les définitions des angoisses, puis les distinguer des relations d'objet et des défenses auxquelles le cours les associe.

01 Définir la psychopathologie et situer la souffrance

La psychopathologie étudie les troubles et la souffrance psychiques : leur description, leur organisation, leurs mécanismes et leur évolution. Elle cherche à comprendre le fonctionnement du sujet, son expérience et ce qui donne sens à ses difficultés. La souffrance constitue un dénominateur commun des définitions du cours, mais elle peut être exprimée par l'entourage lorsque le sujet ne reconnaît pas ses troubles.

Il faut distinguer le champ étudié et la singularité du patient. La pathologie du psychologique examine les phénomènes inhabituels ou morbides ; la psychologie du pathologique considère globalement l'expérience de la personne ; la clinique du pathologique s'attache à sa manière singulière de souffrir. Deux personnes ayant le même diagnostic ne vivent donc pas nécessairement la même expérience.

Le cours retient trois paramètres : un objet, la souffrance psychique ; une méthode, clinique ou expérimentale ; un champ proche de la psychiatrie, avec un accent sur la compréhension. La psychiatrie comprend également la thérapeutique, la prophylaxie et la réadaptation. La psychologie clinique ne se limite pas, quant à elle, aux maladies mentales.

Les définitions du support sont complémentaires : Piéron insiste sur décrire, classer, expliquer les mécanismes et suivre l'évolution ; Pedinielli ajoute explicitement évaluer, diagnostiquer, aider et traiter, quelle que soit l'origine de la souffrance ; Ménéchal retient la science de la souffrance psychique ; Samacher mentionne maladies mentales, fonctionnement anormal et conduites pathologiques.

> **À retenir**
>
> Comprendre une personne implique de relier les manifestations observées à son vécu, à son fonctionnement habituel et à son environnement. Une catégorie diagnostique ne résume pas son identité.

02 Normal et pathologique : raisonner avec plusieurs repères

Deux écueils se répondent : pathologiser le normal, par exemple assimiler des pleurs isolés à une dépression ; normaliser le pathologique, par exemple banaliser l'expression d'un souhait de mourir. Une originalité, une conduite rare ou une différence culturelle ne constituent pas, à elles seules, une maladie.

Les critères présentés sont la déviance sociale, le handicap, le contact avec la réalité, le comportement désadapté, la culture et la rareté. Leur interprétation demande de croiser l'histoire du sujet, son contexte et le retentissement réel. La déviance dépend de normes individuelles et sociales ; elle n'est pas un critère absolu ni intemporel.

Trois paramètres organisent l'analyse : la conscience de la réalité ; l'intensité et la durée de la souffrance ou de la plainte ; la limitation, la menace ou le danger pour soi ou pour autrui. L'absence de plainte ne suffit pas à rassurer : l'anosognosie peut empêcher la personne de reconnaître sa maladie.

Une tristesse de deuil ou une anxiété après une agression peuvent être des réponses compréhensibles. On examine leur intensité, leur persistance, leur contexte et leur retentissement. Inversement, une réaction inhabituelle ou une absence de réaction attendue invite à explorer sans conclure automatiquement à un trouble. Le contexte culturel éclaire les croyances, mais ne dispense pas d'évaluer l'adaptation et les difficultés.

Repère	Questions à se poser
Réalité et culture	Comment la personne distingue-t-elle les faits, les perceptions et les croyances ? Son vécu est-il partagé dans son groupe culturel ?

Repère	Questions à se poser
Souffrance et temporalité	Depuis quand ? À quelle intensité ? Quel changement par rapport à son état antérieur ? Que rapporte l'entourage ?
Fonctionnement et sécurité	Quels effets sur les activités, les relations, les apprentissages ou le travail ? Existe-t-il une menace pour la personne ou pour autrui ?

Application

Une personne qui pleure doit être écoutée dans son contexte. Une personne qui évoque la mort nécessite que cette parole soit prise au sérieux et transmise à l'équipe ; on ne la banalise pas sous prétexte qu'elle semble calme.

03 Pathoplasticité et causalité multiple

La pathoplasticité désigne les variations de l'expression d'un trouble selon les sujets, les observateurs, la culture, le lieu, l'époque et les situations. Le cours compare la grande crise hystérique décrite par Charcot aux expressions plus diverses rencontrées ensuite ; l'apparition d'un nom diagnostique et l'existence antérieure d'une souffrance ne sont pas la même chose.

Quatre arguments l'éclairent : épistémologique, car les théories proposent des grilles différentes ; socioculturel, car les normes et les significations varient ; temporel ou diachronique, car l'expression évolue au cours du temps ; scientifique, car les études épidémiologiques et longitudinales affinent la connaissance des trajectoires. L'âge de début, le mode d'entrée, les épisodes et la précocité des soins influencent les tableaux observés.

Les trois hypothèses étiologiques classiques sont la psychogenèse, l'organogenèse et la sociogenèse. Le modèle bio-psycho-social les articule : une vulnérabilité biologique, une histoire psychique et un contexte social peuvent interagir. Une cause psychologique ne signifie pas que la souffrance est inventée ; une explication biologique ne supprime pas la dimension relationnelle.

L'oral prend l'exemple de l'effet placebo pour rappeler qu'un facteur psychologique ou relationnel peut s'accompagner d'effets corporels. Il ne faut donc pas opposer « psychologique » à « réel » ou imaginer que le biologique et le psychique s'excluent. Les pourcentages avancés approximativement dans la discussion ne sont pas retenus comme des constantes.

Hypothèse	Ce qu'elle privilégie
Psychogenèse	Facteurs psychologiques et mécanismes fonctionnels ; dans la psychanalyse, le symptôme est relié à la vie psychique inconsciente et possède un sens.
Organogenèse	Facteurs organiques : lésions, fonctionnement cérébral, mécanismes neurochimiques, vulnérabilités génétiques et épigénétiques.
Sociogenèse	Conditions sociales susceptibles de favoriser les troubles : situations de vie, insécurité, précarité, ressources et accès aux soins. Aucun déterminisme individuel ne se déduit d'un seul facteur.

Précision de cours

Une même manifestation peut recevoir plusieurs lectures. La grille théorique oriente les questions du clinicien ; elle ne transforme pas son hypothèse en preuve certaine.

04 Les différentes lectures du symptôme

Le symptôme est un point de départ de la rencontre clinique. Il peut signaler une modification émotionnelle, cognitive ou comportementale du fonctionnement habituel. Le patient et l'entourage peuvent en percevoir des aspects différents. Écouter ce que la personne en dit reste nécessaire, quelle que soit l'approche choisie.

Le support répartit les approches en quatre ensembles : personnalistes, centrées sur le sujet et les facteurs individuels ; environnementalistes, centrées sur les situations et les apprentissages ; interactionnistes, centrées sur les relations entre personne et contexte ; syncrétiques, articulant plusieurs démarches. Ce classement sert à comprendre leurs points d'attention.

L'approche biologique recherche des déterminants organiques et interprète le symptôme comme l'indice d'un dysfonctionnement biologique. Le support insiste aussi sur la nécessité de ne pas réduire le soin à ce seul niveau. Ce chapitre compare des conceptions du soin ; il ne constitue pas une prescription thérapeutique individuelle.

Approche	Lecture du symptôme et direction de travail
Biologique · personnaliste	Dysfonctionnement organique ou cérébral ; prise en compte des dimensions médicales et biologiques de la souffrance.
Béhavioriste · environnementaliste	Apprentissage dysfonctionnel et conditions qui le maintiennent ; repérage des variables de l'environnement et réapprentissage.
Systémique · interactionniste	Manifestation inscrite dans un système relationnel ; travail sur la communication, les règles et les ressources de ce système.
TCC · syncrétique	Interaction entre apprentissages, pensées, croyances, émotions et comportements ; objectifs et exercices construits avec le patient.
Psychanalytique · personnaliste	Formation ayant un sens dans l'histoire du sujet ; recherche des conflits, défenses et modalités relationnelles inconscientes.

05 Apprentissages, système relationnel et TCC

Dans le modèle comportemental, les conduites normales et problématiques sont soumises aux lois de l'apprentissage. Le conditionnement classique associe un stimulus à une réponse ; le conditionnement opérant modifie la fréquence d'un comportement par ses conséquences ; l'apprentissage vicariant repose sur l'observation d'un modèle. L'histoire des apprentissages et les conditions de maintien du symptôme sont donc examinées.

Exemple donné en cours : après une morsure, la présence d'un chien peut devenir un signal de peur. L'exemple illustre un conditionnement ; il ne prétend pas expliquer toutes les phobies. Un comportement peut également être entretenu par l'attention qu'il provoque ou par l'évitement d'une situation pénible.

La systémique, associée dans le support à Bateson et à l'école de Palo Alto, remplace une causalité seulement linéaire par une lecture circulaire. Les réactions de chacun influencent celles des autres. Le patient désigné porte le symptôme dans ce système. Cette lecture vise les relations et leurs possibilités de changement ; elle n'autorise pas à attribuer automatiquement une faute à la famille.

Un premier niveau de changement modifie des éléments à l'intérieur du système ; un second transforme ses règles de fonctionnement. La métacommunication consiste à échanger sur la manière de communiquer. Le

thérapeute aide le système à reconnaître ses règles et à mobiliser ses propres ressources.

Les TCC, associées à Ellis et Beck, articulent les apprentissages aux schémas cognitifs, aux interprétations et aux émotions. Une situation interprétée comme toujours dangereuse peut favoriser anxiété, ruminations et évitement. L'inconscient cognitif désigne ici des processus non conscients ; il ne se confond pas avec l'inconscient conflictuel de la psychanalyse.

Le travail présenté suit une analyse du problème dans l'ici et maintenant, la définition partagée des buts et moyens, puis des exercices adaptés et l'évaluation des progrès. Les exercices peuvent être comportementaux, cognitifs, émotionnels ou corporels, en séance et entre les séances. La durée n'est pas un nombre fixe valable pour tous.

Les exercices TCC peuvent chercher à modifier les pensées, émotions et conduites, mais aussi à développer leur acceptation quand leur modification n'est pas possible. L'exemple oral de phobie illustre une confrontation progressive, définie et évaluée avec le thérapeute ; les distances citées servent d'image et ne constituent pas un protocole universel. Le choix de la démarche tient aussi compte de la demande et du mode de travail accepté par le patient.

Le travail avec un système ne se réduit pas à recevoir tous les membres ensemble. L'oral donne l'exemple d'entretiens avec les parents séparément ou d'un soutien aux proches lorsqu'un patient ne peut pas participer à la consultation. L'objectif est d'ouvrir des possibilités relationnelles et de mobiliser les ressources, pas de désigner un responsable unique.

À retenir

Savoir préciser ce qui est observé, la grille utilisée et ce qui reste hypothétique. L'alliance et l'écoute comptent dans la rencontre, au-delà des différences entre techniques.

06 Psychanalyse : histoire, inconscient et symptôme

La psychanalyse est présentée sous trois aspects indissociables : procédé d'investigation du psychisme inconscient, méthode de traitement et théorie issue de cette expérience. Le cours la mobilise pour penser la complexité et la singularité de la relation soignant-soigné.

L'hystérie, dans son sens historique, rassemble des manifestations fonctionnelles très diverses. L'absence de lésion explicative ne signifie ni simulation ni absence de souffrance. Le découpage décrit est celui d'un corps vécu ou fantasmatique. Cette présentation historique ne permet pas d'attribuer une douleur ou un trouble moteur à une cause psychique sans évaluation clinique.

Charcot décrit des prodromes puis quatre périodes de la grande crise : phase épileptoïde, contorsions ou clownisme, attitudes passionnelles ou poses plastiques, phase terminale. Les prodromes précèdent ces quatre périodes. L'hypnose et la suggestion post-hypnotique servent, dans ce récit historique, à penser des processus actifs dont le sujet n'a pas conscience.

Avec Breuer et le cas Anna O., la méthode cathartique relie la mise en récit à la décharge des affects restés attachés à une situation pénible. La talking cure désigne la cure par la parole ; l'abréaction, la décharge émotionnelle. Freud privilégiera ensuite les associations libres : dire ce qui vient à l'esprit pour explorer les liens psychiques.

La théorie de la séduction situe l'origine de certaines névroses dans des traumatismes sexuels précoces. La théorie du fantasme reconnaît ensuite l'importance de la réalité psychique et des désirs conflictuels. Le cours précise que la seconde n'annule pas la réalité des violences. Un fantasme n'est pas la preuve d'un fait ; l'existence de fantasmes ne permet pas de nier une violence subie.

Dans cette lecture, le symptôme constitue une formation de compromis entre désir et défense. Il maintient sous une forme transformée quelque chose du désir, tout en exprimant l'interdit et le déplaisir associés. Le cas historique d'Élisabeth illustre ce raisonnement ; il ne constitue pas une règle diagnostique applicable à toute difficulté de marche.

Dans cette lecture, un symptôme peut contenir provisoirement l'angoisse. L'oral précise que sa disparition sans autre moyen d'élaboration peut s'accompagner d'une remontée de l'angoisse ou de l'apparition d'une autre manifestation : c'est la question de la migration du symptôme. Cette possibilité n'est ni systématique ni une raison de s'opposer au traitement ; elle invite à associer soulagement, compréhension de la fonction et soutien d'autres moyens d'expression.

Dans les exemples oraux, le traumatisme ne se limite pas à un événement physique ou sexuel isolé : le cours invite aussi à penser des expériences relationnelles répétées qui débordent les capacités psychiques. La manière dont une parole de violence est accueillie peut compter dans le vécu et dans la possibilité d'élaboration. Ces formulations appartiennent à la grille proposée ; elles ne permettent pas d'inférer un traumatisme précis à partir d'un symptôme.

Comprendre sans culpabiliser

L'hypothèse d'une fonction psychique du symptôme n'en fait pas un choix volontaire. Les violences relèvent de la responsabilité de leur auteur ; les notions de fantasme et de répétition ne doivent pas servir à culpabiliser une victime.

07 Rêve et formations de l'inconscient

Le rêve, les lapsus, les actes manqués et certains symptômes sont étudiés comme des formations de l'inconscient. La même logique de conflit peut se retrouver dans la vie ordinaire : le modèle insiste ainsi sur une continuité entre fonctionnement normal et pathologique, sans assimiler une maladresse isolée à une maladie.

L'oral distingue le contenu latent, constitué des pensées et désirs sous-jacents, du contenu manifeste, récit du rêve. Un reste diurne peut réactiver un contenu psychique. La condensation rassemble plusieurs éléments en un ; le déplacement reporte une intensité sur un autre élément ; la figuration traduit les pensées en images. L'élaboration secondaire contribue à organiser le récit.

L'interprétation psychanalytique s'appuie sur les associations du rêveur. Il n'existe pas, dans cette démarche, de dictionnaire universel donnant le sens certain d'une image. Une association proposée reste à confronter à l'histoire et aux associations du sujet.

08 Appareil psychique et quatre caractéristiques de la pulsion

L'appareil psychique est un modèle de compréhension, et non un organe localisable. Il sert à représenter le travail qui maîtrise, réduit ou transforme les excitations venant de l'intérieur et de l'extérieur. Le principe de constance exprime la recherche d'un niveau d'excitation aussi bas que possible dans ce modèle.

La pulsion est une poussée d'origine somatique imposant un travail au psychisme. Contrairement à une excitation externe que l'on peut fuir, l'excitation interne persiste. Contrairement à l'instinct décrit dans le support, la pulsion ne détermine pas un comportement rigide identique pour tous : son objet et ses voies de satisfaction dépendent de l'histoire du sujet.

Ses deux représentants psychiques sont l'affect et la représentation. L'affect désigne la tonalité ou qualité émotionnelle associée, agréable ou désagréable, ponctuelle ou durable. La représentation est un contenu de

pensée, une idée ou une image soutenue par des traces mnésiques. Le cours distingue les représentations de mots et de choses.

Caractéristique	Définition et exemple oral
Poussée	Charge énergétique et aspect moteur de la pulsion : ce qui exerce une pression et pousse à l'action.
Source	Processus somatique à l'origine de l'excitation ; pour la pulsion orale, la zone buccale et les zones associées.
But	Satisfaction finale par suppression de l'état d'excitation à sa source, décharge ou disparition de la tension ; les voies intermédiaires sont multiples. Oralement : succion ou incorporation réelle ou fantasmatique.
Objet	Ce par quoi la satisfaction peut être atteinte : personne entière, partie de personne, objet réel ou fantasmatique ; sein ou substitut, pouce, etc.

À retenir

Poussée = force ; source = origine corporelle ; but = satisfaction recherchée ; objet = moyen de l'atteindre. Le terme « objet » ne désigne pas seulement une chose matérielle.

09 Le point de vue topique : systèmes et instances

Topique vient de topos, le lieu. Ce point de vue distingue des systèmes ou instances selon leurs fonctions et leurs lois. Il s'agit d'une représentation du psychisme ; les « lieux » ne correspondent pas à des régions anatomiques du cerveau.

La première topique distingue perception-conscience, préconscient et inconscient. Le préconscient ne contient pas ce qui est actuellement pensé, mais ce qui peut être rappelé assez facilement : l'oral utilise les tables de multiplication. L'inconscient comprend notamment les représentants refoulés qui restent actifs et cherchent à revenir sous une forme transformée.

Dans ce modèle, l'inconscient se caractérise par l'atemporalité, l'absence de contradiction et de négation, l'indifférence à la réalité extérieure et la libre circulation de l'énergie. La censure limite l'accès des représentations à la conscience ; le pare-excitation protège contre un excès d'excitations externes. L'oral souligne le rôle protecteur de l'environnement au début de la vie.

L'oral emploie la notion de carence du préconscient pour proposer une lecture de certains courts-circuits de la pensée : des représentations trop chargées d'affects deviennent difficiles à mobiliser, et l'action peut se substituer à l'élaboration. Il s'agit d'une hypothèse de compréhension de certaines situations, qui ne définit pas à elle seule une addiction, un trouble alimentaire ou un passage à l'acte.

La deuxième topique ajoute les instances Ça, Moi et Surmoi pour penser notamment les identifications, les idéaux et les conflits. Elle complète la première et ne lui correspond pas terme à terme : le Moi comprend aussi une part inconsciente, notamment défensive.

Système / instance	Fonction dans le modèle
Perception-conscience · Pc-Cs	Réception des perceptions externes et internes, sensations de plaisir-déplaisir, pensée consciente, contrôle moteur ; pas de stockage durable des traces dans ce système.

Système / instance	Fonction dans le modèle
Préconscient · Pcs	Contenus momentanément hors de la conscience mais accessibles ; énergie plutôt liée et représentations de mots.
Inconscient · Ics	Contenus refoulés et désirs infantiles, proches de la source pulsionnelle ; processus primaires et représentations de choses.
Ça	Pôle pulsionnel et réservoir d'énergie, inconscient ; recherche de satisfaction sans jugement moral.
Moi	Médiation entre Ça, Surmoi et réalité ; adaptation, unité et identité issues des identifications ; mobilisation des défenses.
Surmoi / Idéal du Moi	Intériorisation des exigences et interdits parentaux, sociaux et culturels ; auto-observation, conscience morale et idéaux. L'idéal désigne ce que le sujet voudrait être.

Culpabilité et honte

L'oral distingue la culpabilité, liée à la transgression d'un interdit ou au sentiment d'avoir fait du mal, de la honte, qui touche l'image de soi et l'écart à l'Idéal du Moi.

10 Le point de vue économique : plaisir, réalité et investissement

Le point de vue économique étudie les quantités d'excitation, leur augmentation, leur diminution et leur circulation. Le principe de plaisir recherche la satisfaction et l'évitement du déplaisir ; le principe de réalité modifie cette recherche en imposant délais et détours compatibles avec le monde extérieur.

L'oral insiste sur la construction progressive de la capacité d'attendre. Des expériences répétées de satisfaction dans un environnement fiable permettent de se représenter un plaisir à venir. Les exemples d'attente du nourrisson ne constituent pas des durées normatives à mémoriser.

Les processus primaires caractérisent l'inconscient : énergie libre, condensation et déplacement. Les processus secondaires caractérisent surtout le préconscient et le conscient : énergie liée, jugement, raisonnement et action contrôlée, avec satisfaction différée. La maladie peut favoriser une régression transitoire vers des exigences plus immédiates.

La libido est l'énergie des pulsions sexuelles au sens élargi de la théorie. Elle peut investir des représentations, le corps, des objets ou des activités. La libido narcissique investit le Moi ; la libido objectale investit les objets extérieurs. Elle ne mesure pas la fréquence des rapports sexuels.

La compulsion de répétition décrit la reprise de situations ou d'expériences pénibles, qui ne se comprend pas par la seule recherche de plaisir. Le cours l'évoque dans les cauchemars traumatiques et les répétitions relationnelles. L'hypothèse d'une tentative inconsciente de maîtrise ne doit pas être transformée en explication unique des conduites.

Dans l'exemple du deuil, le travail psychique implique un remaniement des investissements et la conservation d'un lien intérieur avec l'objet perdu. L'introjection permet de garder des traces de l'autre en soi ; elle ne se limite pas au deuil et participe aussi à la capacité de supporter une séparation.

11 Conflit, dualismes pulsionnels et étayage

Le point de vue dynamique considère le jeu des forces opposées. Un conflit psychique oppose des exigences internes contraires : désir et interdit, désir et défense, ou exigences des instances. Il peut être manifeste ou latent et s'exprimer de manière transformée. Le conflit est constitutif de la vie psychique dans ce modèle.

Le premier dualisme oppose pulsions d'autoconservation et pulsions sexuelles. Les premières visent la survie de l'individu par les fonctions corporelles ; les secondes recherchent le plaisir. Elles peuvent entrer en conflit, mais s'appuient initialement sur les mêmes fonctions corporelles.

L'étayage décrit cet appui initial : l'activité répondant à un besoin procure en même temps une prime de plaisir qui peut ensuite être recherchée pour elle-même. Le nourrisson peut continuer à téter après avoir satisfait sa faim : cette succion non nutritive illustre la distinction entre besoin et plaisir.

La pulsion sexuelle infantile est partielle : plusieurs sources et buts locaux fonctionnent avant leur organisation sous le primat génital. L'auto-érotisme désigne une satisfaction trouvée dans le corps propre. Le mot « sexuel » possède ici un sens plus large que la génitalité adulte.

Le second dualisme oppose pulsions de vie, qui rassemblent autoconservation et sexualité dans une tendance à la liaison, et pulsion de mort, hypothèse d'une tendance à la réduction complète des tensions et au retour à l'inorganique. Le cours évoque leur intrication ; ce sont des constructions métapsychologiques, pas des forces mesurées directement.

La cécité hystérique sert d'exemple théorique du conflit entre fonctions d'autoconservation et recherche de plaisir : la vision protège dans le monde extérieur et peut aussi servir des désirs vécus comme interdits. Dans l'interprétation historique proposée, le symptôme exprime ce conflit sans simulation. Cet exemple n'autorise pas à déduire une origine psychique d'un trouble visuel sans évaluation clinique.

12 Développement psychosexuel : étapes et remaniements

Les stades sont des repères de la théorie psychanalytique. Leurs limites se chevauchent et leurs enjeux peuvent persister au-delà des âges indiqués. Ils ne constituent ni un calendrier rigide ni un outil suffisant pour diagnostiquer un enfant.

Le stade oral privilégie la zone buccale et l'incorporation. Son objet premier est le sein ou son substitut, objet partiel. Le temps oral primitif met l'accent sur la succion et une faible différenciation sujet-objet ; le temps sadique-oral sur la morsure, la destruction fantasmatique et le début de l'ambivalence. Le sevrage mobilise ces enjeux sans en marquer une fin absolue.

Le stade anal, surtout durant les deuxième et troisième années, articule les acquisitions de maîtrise et le contrôle sphinctérien. La source est la zone anale et intestinale, l'objet les fèces vécues comme partie du corps propre, les buts l'expulsion et la rétention. Les phases expulsive et rétentive mettent en jeu donner, garder et s'opposer. La différenciation dedans-dehors et Moi/non-Moi s'y développe dans cette lecture.

Au stade phallique, à partir d'environ trois ans, la curiosité génitale et les théories sexuelles infantiles prennent de l'importance. Le monisme phallique désigne l'hypothèse freudienne d'une première opposition présence/absence du pénis. Le phallus y prend une valeur de puissance ou de complétude ; il ne se réduit pas à une connaissance anatomique. L'oral rappelle que cette conception a été discutée au sein même de la psychanalyse.

Le complexe d'Œdipe désigne l'ensemble des désirs amoureux et hostiles envers les figures parentales. Dans la forme positive, attirance pour le parent de sexe opposé et rivalité envers celui de même sexe ; dans la forme négative, la distribution s'inverse ; la forme complète comporte leur articulation. Ces descriptions appartiennent

au cadre historique du modèle.

La résolution implique le renoncement à posséder les objets parentaux, l'intériorisation des interdits et les identifications : passer de « avoir » à « être comme ». La triangulation permet de reconnaître qu'une personne aimée peut investir un tiers. L'oral étend cette question aux relations quotidiennes et à la capacité de supporter que l'autre ait d'autres liens.

La latence s'étend approximativement de six-sept ans à la puberté. Ce n'est pas un stade fondé sur une nouvelle zone érogène : elle correspond à un relatif apaisement, à l'inhibition des buts sexuels et à la mobilisation de l'énergie dans les apprentissages, les liens tendres et les activités sociales. L'amnésie infantile est reliée au refoulement dans cette théorie.

La puberté remanie le corps, les identifications et les investissements. Le modèle décrit une réactivation des enjeux œdipiens et une orientation vers des objets amoureux extérieurs aux parents. Une autre lecture du développement suit auto-érotisme, narcissisme et amour d'objet : plaisir local sur le corps propre, investissement du Moi unifié, puis investissement de l'autre.

L'oral relie développement et symptômes par les notions de fixation et de régression : certains investissements ou modes de satisfaction restent privilégiés et peuvent être remobilisés dans une difficulté. Il ne s'agit pas de conclure à une cause unique à partir d'une conduite alimentaire ou d'une habitude ; l'hypothèse doit être replacée dans l'ensemble du fonctionnement et de l'histoire.

Les théories sexuelles infantiles citées portent sur la fécondation, imaginée comme orale, urétrale ou exhibitionniste, et sur la naissance, imaginée comme anale ou ombilicale. Elles illustrent la manière dont l'enfant construit une explication à partir de ce qu'il peut se représenter. Les contenus appartiennent au modèle et ne sont pas des connaissances anatomiques exactes.

À propos de la curiosité sexuelle infantile, l'oral invite à distinguer une manifestation isolée de sa persistance répétée malgré l'explication des limites et de l'intimité. L'âge, le contexte, la répétition et la possibilité pour l'enfant d'intégrer une limite doivent être explorés ensemble ; un signe isolé ne permet pas d'affirmer une violence subie ou une pathologie.

À retenir

Narcissisme ne signifie pas automatiquement égoïsme ou trouble. Il désigne ici l'investissement du Moi, nécessaire au sentiment d'unité, à l'image et à l'estime de soi.

Précision de cours : violences sexuelles et mutilations

L'enseignante souligne l'importance de l'écoute des personnes ayant subi des violences ou mutilations sexuelles et de l'accès à une information sur les consultations spécialisées, dont celles proposant une évaluation des possibilités de reconstruction. Elle rappelle, à travers une situation clinique, que la chirurgie ne résume pas les besoins : le vécu traumatique, la demande de la personne et le moment où elle peut en parler comptent aussi. Les détails opératoires et les données personnelles de la vignette ne sont pas repris.

13 Les angoisses : définitions complètes et distinctions

L'angoisse est présentée à l'oral comme une peur sans objet, ou sans objet clairement défini, traduisant la détresse de l'appareil psychique face à des menaces internes. Dans le modèle, elle peut mobiliser des défenses destinées à protéger l'intégrité psychique.

Deux théories freudiennes se succèdent : dans la première, le refoulement et la non-satisfaction pulsionnelle conduisent à la transformation de la charge affective en angoisse ; dans la seconde, l'angoisse devient un signal d'alarme qui déclenche les opérations défensives du Moi. Le signal atténué se distingue de l'angoisse

automatique liée au débordement.

Angoisses de morcellement : angoisses massives et archaïques de destruction, d'anéantissement, d'annihilation, de dévoration, de mort psychique ou de mort par éclatement. Elles se traduisent par la sensation que le corps part en morceaux ou par le sentiment que l'identité vole en éclats. Elles concernent donc l'unité même de la personne, pas seulement la peur d'une blessure.

Angoisses de perte d'objet, d'abandon ou de séparation : angoisses liées à la séparation ou à la perte d'un objet d'amour, qu'elle soit réelle, anticipée ou fantasmatique. « Objet » signifie ici personne ou relation investie affectivement. L'absence n'a pas besoin d'être effective : l'anticipation d'un départ peut suffire.

Angoisses de castration : angoisses liées à des pertes symboliques et à ce qui atteint le sentiment de puissance ou de complétude. L'atteinte peut concerner la féminité, la virilité, les capacités intellectuelles ou physiques, l'autonomie et l'indépendance. Elles ne se limitent pas à une atteinte réelle des organes génitaux.

Type d'angoisse	Association structurale dans le cours
Morcellement	Relation d'objet de type psychotique ; enjeu d'intégrité et d'unité. Défenses évoquées : déni, clivage et projection.
Perte d'objet	Relation anaclitique, particulièrement décrite dans les états-limites ; dépendance à l'objet externe et enjeux narcissiques.
Castration	Organisation névrotique ; enjeux de perte symbolique, de conflit et d'interdit, avec place du refoulement.

Priorité explicitement soulignée à l'oral

L'enseignante demande la définition générale de l'angoisse et dicte les définitions des trois types. Le tableau associe des notions : il ne remplace pas leurs définitions. Une angoisse de morcellement peut aussi survenir transitoirement dans une expérience extrême ; elle ne suffit pas, isolément, à conclure à une psychose.

14 Structure, relation d'objet et décompensation

La structure est la manière dont la personnalité est organisée dans la lecture psychanalytique. La métaphore du cristal illustre qu'une désorganisation suit des lignes de fragilité préexistantes : l'expression d'une décompensation dépend de l'organisation antérieure. Cette métaphore soutient un raisonnement théorique, sans permettre de prédire avec certitude l'avenir d'une personne.

Le cours présente névrose, psychose et perversion dans la tradition freudienne ; Bergeret distingue deux structures, névrotique et psychotique, et des états-limites conçus comme des astructurations susceptibles d'aménagements divers. Ces cadres ne se superposent pas automatiquement aux catégories descriptives du DSM ou de la CIM.

La relation d'objet désigne la manière d'entrer en relation avec les objets investis. Le mode anaclitique s'appuie fortement sur l'autre pour soutenir le Moi. Dans le tableau du cours, le type de relation, l'angoisse dominante et les mécanismes de défense se comprennent ensemble.

Un symptôme isolé ne signe jamais à lui seul une structure : on met les manifestations en relation, on étudie leur fonction et leur évolution, puis on formule une hypothèse. La distinction névrose-psychose insiste dans le cours sur le rapport à la réalité ; elle ne justifie pas de conclure à partir d'une bizarrerie ou d'un jugement porté sur une personne.

15 Mécanismes de défense : comprendre leur fonction

Les mécanismes de défense sont les opérations par lesquelles le Moi tente de protéger l'intégrité psychique et de réduire une angoisse suscitée par une menace ou un conflit. L'oral insiste sur leur caractère inconscient, avec une exception explicitement volontaire dans la liste : la mise à l'écart.

Ils sont présents chez tous. Leur caractère problématique dépend de leur rigidité, de leur inefficacité, de leur inadéquation à la réalité et de leur usage exclusif. Les regroupements « plutôt névrotiques », « plutôt psychotiques », « divers » et « adaptatifs » indiquent des affinités théoriques, pas une règle diagnostique fondée sur un mécanisme seul.

Chaque mécanisme de la liste officielle est défini séparément dans le lexique final. Pour le reconnaître, il faut identifier ce qui est transformé : accès d'une représentation à la conscience, lien entre représentation et affect, objet visé, but pulsionnel ou rapport à la réalité.

Groupe du support	Mécanismes à distinguer
Plutôt névrotiques	Refoulement, déplacement, isolation, annulation rétroactive, formation réactionnelle, dénégation.
Plutôt psychotiques	Déni, projection, clivage du Moi et clivage de l'objet.
Divers	Renversement en son contraire, retournement contre soi, introjection, identification et identification à l'agresseur, idéalisation, régression, activisme, rationalisation, intellectualisation.
Fort niveau adaptatif	Sublimation, humour appliqué à soi-même, altruisme, mise à l'écart.

Application à la relation de soin

Un patient qui détaille sa maladie sans évoquer ce qu'il ressent peut mobiliser une intellectualisation. Cela reste une hypothèse ; une recherche volontaire d'informations pour diminuer le stress relève d'un autre niveau de raisonnement. On explore le vécu sans dévaloriser ses connaissances.

16 Transfert et position soignante

Le transfert est un déplacement d'affects d'un objet du passé vers un objet du présent, selon une analogie ou association le plus souvent inconsciente. Des attentes, craintes, mouvements d'attachement ou d'hostilité issus d'une relation antérieure se réactualisent dans la relation actuelle. Cette tendance est présentée comme universelle.

Le transfert peut comporter des mouvements positifs et négatifs, parfois simultanés. Il peut constituer un appui pour la relation ou une résistance au travail thérapeutique. L'oral souligne que l'idéalisation ou le rejet d'un soignant ne doivent pas être compris uniquement comme une appréciation personnelle de sa valeur.

Le contre-transfert renvoie aux réactions psychiques du soignant dans cette rencontre. Les repérer aide à réfléchir à la relation et à travailler en équipe. Cette notion est annoncée dans le support sans y faire l'objet d'un développement technique approfondi.

L'oral donne aussi l'exemple du clivage de l'objet : certains soignants sont vécus comme entièrement bons et d'autres comme entièrement mauvais. Si l'équipe reprend cette opposition à son compte, le clivage peut devenir institutionnel. La mise en commun des observations permet de garder une lecture cohérente.

La position de soin consiste à écouter ce que la personne exprime, à ne pas répondre par une contre-attaque à l'hostilité, à examiner les difficultés réelles et à maintenir un cadre professionnel. L'hypothèse transférentielle ne doit jamais dispenser d'écouter une plainte légitime sur les soins.

17 Du recueil sémiologique à l'hypothèse diagnostique

La sémiologie est l'étude des signes ; la sémiologie psychiatrique recueille les symptômes subjectifs rapportés et les signes cliniques observables. Leur association peut former un syndrome. La nosographie organise les descriptions ; une référence nosologique permet de les situer dans un système de compréhension des maladies.

Deux temps sont à distinguer : recueillir les manifestations, en tenant compte de la demande et de son contexte ; puis les mettre en relation pour élaborer une hypothèse diagnostique et étiopathogénique. L'IDE contribue par son observation, l'écoute, la description précise et les transmissions ; cette contribution ne se confond pas avec la pose du diagnostic médical.

Dans la lecture psychanalytique, le bénéfice primaire correspond à l'apaisement du conflit et de l'angoisse par le symptôme. Les bénéfices secondaires sont les avantages conscients ou inconscients associés à la situation de maladie. Ils ne prouvent pas une simulation et ne permettent pas de nier la souffrance.

Chez l'enfant, on replace les difficultés dans la maturation, la dépendance à l'environnement et les relations. Le symptôme peut être labile et servir de modalité d'expression. On recherche son sens, sa place dans l'organisation et son évolution. Un enfant silencieux, retiré ou qui n'alerte pas l'entourage peut souffrir autant qu'un enfant très bruyant.

Le diagnostic aide à identifier les troubles, rechercher les troubles associés ou masqués, communiquer, choisir une stratégie de soins et apprécier l'évolution. Il reste insuffisant pour construire seul un accompagnement : situation sociale, ressources, cognition et perspectives de rétablissement comptent aussi. D'où l'intérêt de l'équipe pluridisciplinaire.

Chez l'enfant, la trajectoire maturative et les relations doivent être appréciées ensemble : les manifestations peuvent être somatiques, comportementales, psychomotrices, intellectuelles, langagières ou psychiques. Le support insiste sur l'intérêt d'une prise en charge précoce et rappelle qu'une série durable de manifestations doit être mise en relation avec l'organisation de la personnalité, au-delà du bruit du symptôme.

À retenir

Décrire d'abord ce qui est dit et observé ; distinguer les faits des interprétations. Comprendre la fonction possible d'un symptôme accompagne son évaluation et les soins. Cela ne constitue pas une raison de différer une réponse à un danger.

18 Classer : fonctions, validité et limites

Une classification met en ordre une multiplicité de phénomènes en classes partageant des caractéristiques. Ses fonctions principales sont la systématisation et le diagnostic. Elle facilite les échanges, la recherche et des stratégies de soin cohérentes, tout en restant une représentation imparfaite de la réalité.

Le support présente la validité externe, adéquation à ce qu'on veut décrire ; la cohérence interne du système ; la fidélité temporelle pour une situation inchangée ; la fidélité inter-juges entre évaluateurs ; la capacité de différenciation et l'utilité pratique. Les notions de sensibilité, faux négatif et faux positif invitent à examiner la justesse du repérage. Une classification peut autoriser plusieurs diagnostics associés : il ne faut pas confondre cohérence et absence de comorbidité.

La démarche catégorielle classe selon la présence de critères ; la dimensionnelle mesure l'intensité ou la fréquence de dimensions ; la typologique décrit des configurations de traits. Une classification peut associer des catégories à des spécifications de sévérité. Une note sur une échelle n'équivaut pas à elle seule à un diagnostic.

Les modèles processuels s'intéressent aux mécanismes qui produisent ou maintiennent les troubles, notamment lorsqu'ils traversent plusieurs diagnostics. Les modèles en réseaux examinent les relations entre symptômes plutôt que de supposer nécessairement une maladie sous-jacente unique. Ces approches cherchent à mieux représenter la complexité.

Approche	Logique et exemple
Catégorielle	Présence/absence de critères et seuil d'inclusion ; approche dominante des systèmes présentés dans le support.
Dimensionnelle	Intensité ou fréquence d'un trait, par exemple anxiété cotée sur une échelle ; suit une variation plutôt qu'une seule case.
Typologique	Profil ou configuration de traits essentiels, sans exiger que tous soient présents.

19 Exemple : les critères d'un épisode dépressif caractérisé

L'exemple du support montre comment fonctionne une liste de critères. Au moins cinq des neuf manifestations doivent être présentes pendant une même période d'au moins deux semaines, avec changement par rapport au fonctionnement antérieur. Au moins l'une doit être l'humeur dépressive ou la perte d'intérêt ou de plaisir.

Les neuf manifestations sont : humeur dépressive ; diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir ; variation significative du poids ou de l'appétit ; insomnie ou hypersomnie ; agitation ou ralentissement psychomoteur observable ; fatigue ou perte d'énergie ; dévalorisation ou culpabilité excessive ou inappropriée ; difficultés de pensée, de concentration ou indécision ; pensées de mort ou idées et conduites suicidaires.

L'illustration précise une présence presque quotidienne pour la plupart des manifestations, et une présence presque toute la journée pour les deux premières. Pour le poids, elle donne comme exemple une variation supérieure à 5 % en un mois hors régime ; chez l'enfant, la non-prise de poids attendue peut être considérée. L'humeur peut être irritable chez l'enfant et l'adolescent.

Il faut aussi une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement, et ne pas attribuer les manifestations aux effets d'une substance ou d'une autre affection médicale. Le contexte d'une perte doit être apprécié cliniquement : une réaction de deuil et un épisode dépressif peuvent nécessiter d'être distingués, sans automatisme.

L'encadré du support distingue l'épisode dépressif des conditions supplémentaires pour retenir un trouble dépressif unipolaire : ne pas mieux expliquer l'épisode par certains troubles psychotiques et ne pas avoir d'antécédent maniaque ou hypomaniaque. Un épisode dépressif peut donc exister dans un trouble bipolaire ; la présence d'un tel antécédent modifie le raisonnement diagnostique.

Manifestation	Précisions de l'encadré officiel
Humeur dépressive	Présente pratiquement toute la journée, presque tous les jours, rapportée par la personne ou observée par autrui ; peut se présenter comme une irritabilité chez l'enfant ou l'adolescent.
Intérêt ou plaisir	Diminution marquée pour toutes ou presque toutes les activités, pratiquement toute la journée et presque tous les jours, rapportée ou observée.

Manifestation	Précisions de l'encadré officiel
Poids ou appétit	Perte ou gain significatif de poids hors régime, avec comme exemple plus de 5 % en un mois, ou diminution ou augmentation de l'appétit presque tous les jours ; chez l'enfant, considérer l'absence de prise de poids attendue.
Sommeil	Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours.
Psychomotricité	Agitation ou ralentissement presque tous les jours, observables par autrui et non réduits au ressenti intérieur de fébrilité ou de lenteur.
Énergie	Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours.
Valeur de soi / culpabilité	Dévalorisation ou culpabilité excessive ou inappropriée, pouvant être délirante, presque tous les jours ; pas seulement un reproche ou une culpabilité d'être malade.
Pensée / décision	Diminution de l'aptitude à penser ou se concentrer, ou indécision, presque tous les jours, rapportée ou observée.
Mort / suicide	Pensées de mort récurrentes ne se limitant pas à la peur de mourir ; idées suicidaires récurrentes, tentative ou projet suicidaire selon la description de l'encadré.

Lire tous les critères

Le nombre et la durée ne suffisent pas : il faut considérer le changement, le retentissement, les exclusions et l'histoire du sujet. Cet exemple sert à apprendre la logique diagnostique, sans constituer un outil d'autodiagnostic.

20 DSM, CIM et classifications historiques

Le DSM est le manuel diagnostique et statistique de l'American Psychiatric Association. Le cours décrit le DSM-5 comme principalement descriptif et catégoriel, fondé sur des critères et visant une position athéorique quant aux causes. Cette intention n'abolit pas les choix de construction du système.

Le support oppose l'ancienne organisation en cinq axes à une présentation non multiaxiale ; il rappelle l'évaluation du retentissement et les correspondances parfois imparfaites avec la CIM. Les spécifications incluent sévérité légère, moyenne ou sévère, rémission partielle ou complète, antécédents et rechute. Un diagnostic provisoire ou non spécifié répond à une situation d'information ou de classement particulière, sans signifier absence de difficulté.

La CIM, Classification internationale des maladies, est portée par l'OMS et concerne l'ensemble des maladies. Le cours la présente comme un outil de comparaison de la mortalité et de la morbidité, puis de description et de codage des troubles. Il compare une logique clinique plus globale à la logique de listes du DSM. Ces présentations servent de repères et ne constituent pas des équivalences parfaites entre systèmes.

La CFTMEA est la Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, associée dans le support à Roger Misès. Elle souligne les perspectives développementale, dynamique et structurale, avec des repères catégoriels et dimensionnels et des possibilités de transcodage.

Les classifications historiques sont à reconnaître comme telles : chez Freud, névroses actuelles (névrose d'angoisse, neurasthénie, hypocondrie), névroses de transfert (hystérique, obsessionnelle, phobique), puis schizophrénie, paranoïa et mélancolie/manie dans le groupe des psychoses. Ces termes ne se convertissent pas mot pour mot en catégories contemporaines.

Dans la tradition française exposée, les psychoses aiguës incluent la bouffée délirante aiguë ; les psychoses chroniques sont divisées en dissociatives (schizophrénie) et non dissociatives (psychose paranoïaque, psychose

hallucinatoire chronique, paraphrénies). L'oral distingue la désorganisation de la pensée d'une « double personnalité », qui ne définit pas la schizophrénie.

Une rémission complète peut être observée sous traitement : l'absence actuelle de symptômes ne signifie pas automatiquement que toute vulnérabilité ou tout besoin de suivi a disparu. L'oral illustre aussi l'intérêt de rechercher plusieurs troubles associés, par exemple un trouble psychotique et une difficulté addictive, plutôt que de laisser la plainte première masquer le reste.

L'oral décrit plusieurs évolutions possibles après une bouffée délirante aiguë : épisode isolé, répétition d'épisodes ou inscription dans une évolution chronique. Les proportions hésitantes de la transcription ne sont pas retenues. La mélancolie est évoquée comme une souffrance dépressive particulièrement grave, avec une attention majeure portée au risque suicidaire ; une parole de mort ne doit pas être banalisée.

Le support présente pour le DSM-5 environ trois cents catégories regroupées en vingt et une grandes classes. Ces nombres décrivent la présentation étudiée. Les spécifications de sévérité associent nombre de symptômes, intensité et retentissement. La CFTMEA articule lecture développementale, dynamique et structurale avec des repères catégoriels et dimensionnels ; son transcodage avec la CIM facilite des usages communs sans rendre les concepts identiques.

À retenir

Classer aide à décrire et à communiquer. Comprendre et accompagner exige aussi l'histoire, le vécu, les relations, les ressources et l'évolution de la personne.

21 Pièges QCM / confusions à éviter

Comparer les notions proches en formulant ce qui change : le niveau observé, la fonction psychique, le rapport à la réalité ou la logique de classement.

Confusion	Distinction à retenir
Rareté = maladie	Un comportement rare ou culturellement différent n'est pas pathologique à lui seul.
Pas de plainte = pas de trouble	La personne peut méconnaître son trouble ; le vécu de l'entourage et le fonctionnement comptent.
Modèle psychique = anatomie	Topiques, Ça, Moi et Surmoi sont des modèles théoriques.
Pulsion = instinct = impulsion	La pulsion est une poussée avec source, but, objet et pression ; instinct et passage à l'acte impulsif désignent autre chose.
Libido = rapports sexuels	C'est l'énergie des pulsions sexuelles au sens élargi, qui peut investir des activités.
Tableau des angoisses = définitions	Définir leur vécu et leur objet ; ne pas réciter seulement leur association structurale.
Déni = refus volontaire	Le déni est inconscient ; exprimer un doute ou dire « je n'arrive pas à y croire » ne suffit pas à l'identifier.
Dénégation = déni	La dénégation refuse de reconnaître un contenu qui vient d'être formulé ; le déni porte sur une réalité perçue.
Refoulement = mise à l'écart	Le refoulement est inconscient ; la mise à l'écart est volontaire dans la liste du cours.

Confusion	Distinction à retenir
Isolation = intellectualisation	Isolation : dissocier représentation et affect ; intellectualisation : privilégier l'abstraction face à l'affect.
Rationalisation = raisonnement exact	Elle fournit une justification apparemment logique masquant les motifs inconscients.
Clivage du Moi = clivage de l'objet	Deux attitudes coexistent dans le Moi ; l'objet, lui, peut être séparé en tout bon / tout mauvais.
Régression = perte définitive	Elle peut être transitoire, notamment dans la maladie.
Bénéfice secondaire = simulation	Un avantage lié à la maladie ne prouve pas que le symptôme est fabriqué.
Un symptôme = une structure	Il faut relier les manifestations ; l'hypothèse reste à confronter.
Cinq symptômes = diagnostic complet	Durée, changement, retentissement, exclusions et histoire sont nécessaires.
Manie antérieure = aucun épisode dépressif	Un épisode dépressif peut s'inscrire dans un trouble bipolaire.
Fidélité = vérité	Accord des évaluateurs et stabilité ne garantissent pas à eux seuls la validité de la catégorie.
Schizophrénie = double personnalité	Le cours insiste sur la désorganisation des associations et de la pensée.

22 Synthèse générale — L'essentiel du cours

1. La psychopathologie étudie et cherche à comprendre la souffrance et les troubles psychiques. Le normal et le pathologique s'apprécient en contexte, à partir de plusieurs critères et du retentissement.

2. La pathoplasticité explique la variabilité des expressions. Les hypothèses psychogénétique, organogénétique et sociogénétique s'articulent dans une perspective bio-psycho-sociale.

3. Les approches biologique, comportementale, systémique, cognitive et psychanalytique éclairent différemment un même symptôme. Nommer la grille permet de situer ce qui est observation ou interprétation.

4. La métapsychologie étudie le psychisme sous les angles topique, économique et dynamique. Retenir les quatre caractéristiques de la pulsion, les deux topiques, plaisir-réalité, investissement, conflit et étayage.

5. Le développement psychosexuel est un modèle théorique : oral, anal, phallique et Œdipe, latence, puberté. Ses étapes ne sont pas des frontières d'âge rigides.

6. Les angoisses concernent l'intégrité (morcellement), le lien à l'objet d'amour (séparation) ou une perte symbolique de puissance/complétude (castration). Les défenses protègent le Moi et deviennent problématiques surtout par leur rigidité et leur inadéquation.

7. Transfert, contre-transfert et effets du clivage éclairent la relation. Ils demandent de réfléchir en équipe, sans réduire la personne à un diagnostic ni disqualifier sa parole.

8. Recueillir signes et symptômes précède leur regroupement en syndrome et l'hypothèse diagnostique. Les classifications facilitent le soin et la recherche ; elles ne remplacent ni la clinique singulière ni l'évaluation du contexte.

23 Définitions et mots-clés

Lexique organisé selon les thèmes du support. Les termes historiques ou seulement cités sont identifiés comme tels : leur définition de repérage ne remplace pas des critères diagnostiques qui ne sont pas enseignés dans ce document.

Champ, normalité et causalité

29 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Psychopathologie	Discipline qui étudie les troubles et la souffrance psychiques. Piéron en souligne la description, la classification, les mécanismes et l'évolution. Pedinielli la situe comme une sous-discipline de la psychologie ayant pour objet l'évaluation, le diagnostic, l'aide et le traitement de la souffrance psychique, quelle que soit son origine. Ménéchal la présente comme la science de la souffrance psychique ; Samacher étend sa définition à l'étude des maladies mentales, du fonctionnement mental anormal et des conduites pathologiques. Son objet est la souffrance psychique, sa méthode clinique ou expérimentale, et son champ est proche de celui de la psychiatrie, avec un accent sur la connaissance et la compréhension.
Souffrance psychique	Expérience pénible concernant la vie mentale et affective. Elle peut être exprimée par la personne ou repérée par son entourage, et s'apprécie avec son intensité, sa durée, son contexte et son retentissement.
Psychologie clinique	Démarche de compréhension et d'étude du sujet dans sa singularité et dans sa situation. Son champ ne se limite pas aux maladies mentales.
Psychiatrie	Discipline médicale qui prend en charge les troubles psychiques, avec des dimensions diagnostiques, thérapeutiques, préventives et de réadaptation.
Normalité	Repère relatif à des normes individuelles, sociales et culturelles. Elle ne se confond ni avec la fréquence statistique d'un comportement ni avec l'absence de toute souffrance.
Pathologique	Ce qui relève d'un trouble ou d'un processus morbide, apprécié à partir d'un ensemble de manifestations, du vécu, du contexte et du retentissement ; aucun critère isolé ne suffit systématiquement.
Pathologisation du normal	Attribution injustifiée d'un caractère maladif à une variation ordinaire, comme assimiler toute tristesse à une dépression.
Normalisation du pathologique	Banalisation d'une manifestation préoccupante, dont la souffrance ou le danger mérite pourtant une évaluation.
Déviance sociale	Écart à une norme sociale ou individuelle. Sa signification dépend du contexte historique et culturel ; elle ne constitue pas en soi un diagnostic.
Handicap et limitation	Limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le support l'utilise comme repère de retentissement, à replacer dans l'environnement réel.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Contact avec la réalité	Capacité à situer ses perceptions, pensées et expériences par rapport au monde partagé, en tenant compte du contexte culturel et de l'adaptation concrète.
Comportement désadapté	Conduite qui ne permet pas de répondre de façon adéquate à la situation ou entraîne des difficultés de fonctionnement. Son appréciation nécessite le contexte.
Anosognosie	Méconnaissance par la personne de l'existence de son trouble. Elle ne se confond pas avec un mensonge volontaire ni, automatiquement, avec le déni psychanalytique.
Pathoplasticité	Variation de l'expression d'un trouble selon le sujet, l'observateur, la culture, le lieu, l'époque et les situations dans lesquelles il apparaît.
Épistémologie	Réflexion sur les connaissances scientifiques, leurs méthodes et leurs cadres théoriques. Dans le cours, elle aide à comprendre pourquoi des approches lisent différemment un même trouble.
Diachronie	Étude d'un phénomène dans son évolution temporelle ; elle s'oppose à une lecture limitée à un seul moment.
Épidémiologie	Étude de la fréquence et de la répartition des phénomènes de santé dans des populations et des facteurs qui leur sont associés.
Étude longitudinale	Étude suivant des sujets ou des phénomènes au fil du temps pour observer leur évolution.
Étiologie	Étude des causes d'une maladie ou ensemble des facteurs auxquels sa survenue est rapportée.
Psychogenèse	Hypothèse selon laquelle les facteurs et mécanismes à l'origine des manifestations psychopathologiques sont psychologiques et fonctionnels, c'est-à-dire sans lésion ni inflammation structurale dans la formulation du support. La psychanalyse relie ainsi le symptôme à la vie psychique inconsciente et à son sens. Il s'agit d'une hypothèse étiologique ; elle ne permet pas de déclarer une origine psychique par le seul constat d'un examen sans anomalie.
Organogenèse	Hypothèse rapportant les troubles à des facteurs organiques, structurels ou fonctionnels, notamment cérébraux, neurochimiques ou génétiques.
Sociogenèse	Ensemble des facteurs sociaux susceptibles de favoriser ou de contribuer à la survenue de troubles psychiques ; elle ne signifie pas qu'un contexte détermine à lui seul le devenir individuel.
Modèle bio-psycho-social	Cadre de compréhension articulant dimensions biologiques, psychologiques et sociales dans leurs interactions, plutôt que recherchant une cause unique.
Prophylaxie	Ensemble des mesures destinées à prévenir la survenue ou la diffusion d'une maladie ; le support la cite parmi les dimensions du champ psychiatrique.
Réadaptation	Processus visant à soutenir le fonctionnement, l'autonomie et la participation à la vie ordinaire en tenant compte des difficultés et des ressources.
Pathologie du psychologique	Lecture de la psychologie centrée sur ses aspects inhabituels, rares, pathologiques ou affectés d'un indice de morbidité ; premier axe de Lantéri-Laura dans le support.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Psychologie du pathologique	Lecture globale et holistique de l'expérience vécue d'un patient, qui ne se limite pas à ce qui produit la souffrance ; deuxième axe de Lantéri-Laura.
Clinique du pathologique	Lecture centrée sur la singularité de l'expérience de souffrance psychique de chaque sujet ; troisième axe de Lantéri-Laura.
Fonctionnel / lésionnel	Dans les distinctions du support, fonctionnel qualifie une perturbation du fonctionnement sans lésion structurale explicative ; lésionnel renvoie à une atteinte de structure. Cette distinction descriptive ne démontre pas à elle seule une cause psychologique.

Approches et apprentissages

26 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Psychothérapie	Démarche thérapeutique utilisant des moyens psychologiques et une relation structurée pour travailler une souffrance ou des difficultés psychiques ; ses objectifs et méthodes dépendent du cadre choisi.
Approche personnaliste	Dans le classement du support, approche centrée sur le sujet et les facteurs individuels ; elle comprend notamment les lectures psychanalytique, biologique et cognitive.
Approche environnementaliste	Approche privilégiant l'environnement du sujet : situation-problème, contexte, culture et facteurs situationnels. Le support y classe les psychothérapies comportementales, ethnopsychologiques et sociales.
Approche interactionniste	Approche tenant compte des contributions de la personne et de la situation, mais aussi de leur interaction : relations et influences réciproques entre personne et contexte. Le support y situe les psychothérapies systémiques et écosystémiques.
Approche syncrétique	Dans le support, démarche qui va au-delà de la simple juxtaposition de techniques pour articuler plusieurs approches dans un modèle de causalité multiple et bidirectionnelle. Les TCC combinent la démarche comportementale et les stratégies cognitives, avec une place pour les émotions.
Approche biologique	Lecture recherchant les éléments organiques des troubles et les modifications du fonctionnement du système nerveux susceptibles d'y contribuer.
Béhaviorisme	Approche centrée sur les comportements observables et leurs lois d'apprentissage, en particulier les conditions de leur acquisition et de leur maintien.
Conditionnement classique ou répondant	Apprentissage par association de stimuli, par lequel un stimulus initialement neutre peut déclencher une réponse ; l'exemple classique est celui du signal associé à la salivation.
Conditionnement opérant ou instrumental	Apprentissage dans lequel les conséquences d'un comportement influencent sa probabilité de répétition ; il concerne le comportement et ses effets dans l'environnement.
Apprentissage vicariant	Apprentissage reposant sur l'observation des conduites d'un modèle et de leurs conséquences, sans devoir faire soi-même toute l'expérience.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Renforcement	Conséquence qui augmente la probabilité de répétition d'un comportement dans l'apprentissage opérant ; le terme décrit une fonction, pas uniquement une récompense agréable.
Extinction	Affaiblissement d'une réponse apprise lorsque les conditions qui la maintenaient cessent ; l'oral l'évoque à propos des conséquences accordées à une conduite.
Approche systémique	Lecture considérant la personne dans les systèmes auxquels elle appartient et les interactions circulaires qui participent au fonctionnement et à la souffrance.
Système relationnel	Ensemble d'éléments en interaction, par exemple une famille, dont les règles et les échanges influencent les membres et sont influencés par eux.
Causalité circulaire	Manière de comprendre des influences réciproques : chaque réaction agit sur les autres et contribue à entretenir ou modifier le fonctionnement du système.
Patient désigné	Dans le modèle systémique, personne portant le symptôme à travers lequel se manifeste une difficulté relationnelle du système ; ce terme ne signifie pas qu'elle serait volontairement malade.
Métacommunication	Communication portant sur la manière dont on communique : implicites, règles, malentendus, place du verbal et du non-verbal.
Thérapies cognitivo-comportementales · TCC	Approches associant l'histoire des apprentissages à la manière subjective de vivre les situations : pensées, croyances, schémas, émotions et comportements. Elles visent à modifier les fonctionnements inadaptés ou, lorsque cela n'est pas possible, à en développer l'acceptation. Le travail comprend analyse du problème dans l'ici et maintenant, objectifs et moyens définis avec le patient, exercices adaptés en séance et entre les séances, puis évaluation des progrès et de la poursuite du traitement.
Cognition	Ensemble des opérations par lesquelles le sujet traite l'information, se représente les situations, pense, juge et interprète.
Schéma cognitif	Structure issue des expériences et connaissances qui organise les interprétations et oriente pensées, émotions et comportements, parfois sans que le sujet en ait conscience.
Biais cognitif	Orientation ou déformation du traitement de l'information qui influence l'interprétation d'une situation ; le cours l'évoque lorsqu'elle contribue à maintenir la souffrance.
Inconscient cognitif	Processus cognitifs se déroulant hors de la conscience immédiate. Il ne correspond pas nécessairement à des contenus refoulés en conflit avec des interdits.
Rumination	Reprise répétitive de pensées autour d'une difficulté ou d'une inquiétude, susceptible d'entretenir la souffrance sans aboutir à une résolution.
Évitement	Conduite consistant à se tenir à distance d'une situation ou d'un vécu redouté ; elle peut participer au maintien d'un apprentissage problématique.
Alliance thérapeutique	Qualité de la collaboration et du lien de confiance entre personne soignée et professionnel autour du travail de soin ; l'oral la présente comme un facteur relationnel transversal.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Effet placebo	Effet associé notamment aux attentes et au contexte de soin, utilisé à l'oral pour illustrer les interactions entre dimensions psychiques et corporelles. L'exemple vise à éviter d'opposer somatique et psychologique ; les pourcentages approximatifs cités ne sont pas des valeurs à mémoriser.

Histoire et concepts psychanalytiques

31 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Psychanalyse	À la fois procédé d'investigation du psychisme inconscient, méthode de traitement et théorie de la vie psychique issue de cette expérience.
Hystérie	Notion historique désignant des manifestations fonctionnelles diverses, notamment corporelles, interprétées dans le cours en relation avec des conflits psychiques et la conversion. Elle ne se confond pas avec une simulation.
Conversion	Dans le modèle psychanalytique du cours, transposition corporelle d'un conflit ou d'un affect, donnant une expression somatique au symptôme ; cette lecture ne se déduit pas de la seule absence de lésion retrouvée.
Atteinte fonctionnelle	Perturbation d'une fonction sans lésion structurale explicative identifiée dans la présentation considérée ; le trouble est vécu réellement et demande une évaluation clinique.
Corps fantasmatique	Corps tel qu'il est représenté et investi psychiquement, avec une organisation subjective qui ne se confond pas avec le découpage anatomique.
Belle indifférence	Expression historique de Charcot désignant une apparente absence d'inquiétude devant certains symptômes ; elle n'est ni une preuve de simulation ni un critère suffisant de diagnostic.
Prodrome	Manifestation annonciatrice précédant un tableau clinique ; dans la description de Charcot, les prodromes précèdent les quatre périodes de la crise.
Clownisme	Terme historique désignant les contorsions et attitudes corporelles spectaculaires de la deuxième période de la grande crise décrite par Charcot.
Suggestion post-hypnotique	Consigne donnée dans un état hypnotique pouvant influencer ensuite une conduite sans que le sujet se rappelle consciemment la consigne ; le cours l'utilise pour introduire des processus psychiques non conscients.
Méthode cathartique	Méthode historique associant la mise en récit d'événements pénibles à la libération des affects qui leur restent attachés, notamment dans les travaux de Breuer et Freud.
Catharsis	Décharge ou libération émotionnelle ; dans le contexte historique du cours, elle désigne l'apaisement recherché par l'expression d'affects jusque-là retenus.
Abréaction	Décharge émotionnelle d'un affect lié à un événement pénible ou traumatique, obtenue notamment lors de son évocation dans la méthode cathartique.
Talking cure	Expression associée à Anna O. désignant la cure par la parole, dans laquelle la mise en récit participe au travail thérapeutique.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Associations libres	Procédé invitant le sujet à exprimer ce qui lui vient à l'esprit en tentant de limiter la sélection volontaire, afin d'explorer les liens entre ses contenus psychiques.
Réminiscence	Retour d'un souvenir ou d'une trace du passé ; le récit historique de l'hystérie insiste sur l'action persistante de souvenirs chargés d'affects.
Théorie de la séduction	Première hypothèse étiologique freudienne reliant certaines névroses au souvenir de scènes sexuelles traumatiques précoces ; le terme historique ne signifie pas un consentement de l'enfant.
Fantasme	Scénario ou représentation psychique exprimant des désirs et leurs conflits, conscient ou inconscient. Il appartient à la réalité psychique et ne démontre pas à lui seul la réalité matérielle d'un événement.
Réalité psychique	Valeur et effets qu'ont pour le sujet ses représentations, désirs et fantasmes, indépendamment de leur correspondance exacte avec un événement extérieur.
Théorie du fantasme	Hypothèse reconnaissant le rôle des désirs et scénarios psychiques, notamment œdipiens, dans certains conflits ; le cours précise qu'elle n'efface pas la réalité des traumatismes.
Formation de compromis	Production psychique qui exprime de façon transformée des forces opposées, notamment un désir et une défense ; rêve, lapsus et certains symptômes en sont des exemples dans le modèle.
Contenu latent	Pensées, désirs et associations sous-jacents au rêve, distingués de son récit manifeste dans la théorie psychanalytique.
Contenu manifeste	Rêve tel qu'il est vécu et raconté au réveil, après transformation de ses contenus sous-jacents.
Reste diurne	Élément d'une journée qui peut réactiver des contenus psychiques et fournir du matériau au rêve.
Condensation	Processus réunissant plusieurs représentations ou chaînes associatives dans un même élément, par exemple un personnage de rêve combinant plusieurs personnes.
Figuration	Transformation de pensées en images ou en formes représentables dans le rêve, présentée à l'oral comme un des procédés du travail onirique.
Élaboration secondaire	Travail qui contribue à organiser les éléments du rêve en un récit présentant une certaine cohérence.
Lapsus	Erreur de parole ou d'expression interprétable, dans la lecture psychanalytique, comme une manifestation transformée d'un contenu psychique ; son sens ne se conclut pas automatiquement d'une erreur isolée.
Acte manqué	Action ou omission qui échoue au regard de l'intention consciente et peut exprimer, selon le modèle, une tendance inconsciente ; son interprétation nécessite le contexte du sujet.
État hypnoïde	État de conscience modifié, décrit dans le cas historique d'Anna O., au cours duquel un mot lié à ses préoccupations pouvait susciter une narration spontanée. Il est présenté dans l'histoire de la méthode cathartique, sans être assimilé au sommeil ordinaire.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Rêve	Formation étudiée en psychanalyse comme expression transformée de contenus psychiques. L'oral distingue contenu latent et contenu manifeste, et décrit condensation, déplacement, figuration et élaboration secondaire. L'exploration repose sur les associations du rêveur, sans clé symbolique universelle.
Régression topique	Retour, dans la lecture orale du rêve, vers des modalités plus imagées et sensorielles de représentation plutôt que la seule pensée verbale. C'est une modalité de régression dans un modèle de fonctionnement psychique, pas un déplacement anatomique.

Métapsychologie et pulsions

51 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Métapsychologie	Partie théorique de la psychanalyse décrivant les processus psychiques selon les points de vue topique, économique et dynamique.
Appareil psychique	Modèle ou fiction représentant un ensemble organisé de systèmes ou d'instances aux fonctions différentes, qui se constitue progressivement en transmettant et transformant les excitations internes et externes. Son travail est de les maîtriser, réduire ou transformer et de maintenir leur niveau aussi bas que possible, par protection contre l'externe et défense ou décharge de l'interne. Il ne désigne pas un organe anatomique.
Excitation	Stimulation interne ou externe qui impose au psychisme un travail de maîtrise, de transformation ou de décharge dans le modèle du cours.
Pulsion	Poussée liée à une source somatique interne, imposant un travail à l'appareil psychique. Elle correspond dans le cours à un afflux constant d'excitations internes auquel on ne peut se soustraire comme à une stimulation extérieure. Elle se caractérise par poussée, source, but et objet. Contrairement à l'instinct décrit dans le support, elle reste relativement indéterminée quant aux conduites, aux buts intermédiaires et aux objets procurant satisfaction, qui dépendent de l'histoire du sujet. Affect et représentation en sont les représentants psychiques.
Poussée pulsionnelle	Aspect moteur et charge énergétique de la pulsion, c'est-à-dire sa pression et ce qui pousse à agir.
Source pulsionnelle	Processus somatique, dans un organe ou une zone du corps, à l'origine de l'excitation représentée psychiquement par la pulsion.
But pulsionnel	Satisfaction finale obtenue, dans le modèle, par suppression de l'état d'excitation à la source pulsionnelle, disparition de la tension ou décharge. Le terme peut également désigner les voies, activités ou mécanismes intermédiaires permettant d'atteindre cette satisfaction ; ces buts peuvent être multiples et parcellaires.
Objet pulsionnel	Ce par quoi ou en quoi la pulsion peut obtenir satisfaction : personne entière, partie de personne, objet réel ou fantasmatique ; il est contingent et dépend de l'histoire.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Instinct	Dans la distinction du support, comportement animal fixé par l'hérédité, caractéristique d'une espèce, relativement stable dans son déroulement, adapté à son objet et variant peu entre individus. Il suit une séquence temporelle peu susceptible de bouleversement et paraît répondre à une finalité. La pulsion est décrite, à l'inverse, comme plus indéterminée quant aux comportements, objets et buts.
Zone érogène	Région corporelle pouvant être source de plaisir dans la théorie, notamment les zones cutanéo-muqueuses et d'échange avec l'entourage ; la notion est ensuite étendue au corps entier.
Affect	Qualité de l'énergie associée à la pulsion, positive ou négative. Le terme peut désigner tout état affectif agréable ou désagréable, vague ou précis, sous forme d'une décharge massive et ponctuelle ou d'une tonalité générale durable, comme l'humeur. Affect et représentation constituent dans le cours les deux représentants psychiques de la pulsion.
Représentation	Contenu de pensée, idée de quelque chose ou image, s'appuyant sur des traces mnésiques. Le support distingue représentations de mots, principalement acoustico-verbales, et représentations de choses, principalement imagées. Avec l'affect, elle constitue un représentant psychique de la pulsion ; dans le refoulement névrotique, c'est la représentation conflictuelle qui est maintenue dans l'inconscient.
Représentation de mot	Représentation verbale, principalement acoustico-verbale dans le support, distinguée des représentations de choses.
Représentation de chose	Représentation essentiellement imagée ou sensorielle d'un objet ou d'une expérience, distinguée de sa formulation verbale.
Trace mnésique	Trace conservée d'une expérience, servant de support au souvenir et aux représentations dans le modèle psychique.
Point de vue topique	Lecture de l'appareil psychique selon des systèmes ou instances ayant des fonctions et règles différentes, sans supposer de localisation anatomique.
Perception-conscience · Pc-Cs	Système situé à la périphérie de l'appareil psychique dans la première topique. Il reçoit les informations extérieures et les sensations internes de plaisir et de déplaisir ; il est le siège des processus de pensée consciente, de l'accès aux souvenirs pour raisonner et du contrôle moteur. Aucune trace durable ne s'y inscrit dans ce modèle ; l'énergie y est mobile, permettant notamment l'attention portée à différents éléments.
Préconscient · Pcs	Système situé entre l'inconscient et la perception-conscience. Ses contenus, notamment les représentations de mots, sont absents du champ actuel de la conscience mais peuvent devenir conscients assez facilement. L'énergie y est plutôt liée. L'oral l'illustre par un savoir disponible, comme des tables de multiplication que l'on rappelle pour effectuer un calcul.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Inconscient · Ics	Partie la plus archaïque de l'appareil psychique, proche des sources pulsionnelles. Ses contenus comprennent notamment les représentants de pulsions et représentations de choses refoulés, dont des désirs infantiles, qui restent actifs et cherchent à revenir dans la conscience et l'action, par exemple dans le rêve, le lapsus ou le symptôme. Dans cette théorie, son fonctionnement comporte absence de contradiction, de négation, de doute et de degré dans la certitude, atemporalité et indifférence à la réalité extérieure, remplacée par la réalité psychique. L'énergie y circule librement.
Censure	Fonction figurée comme une barrière sélective entre inconscient et préconscient. Elle interdit l'accès de certains désirs ou représentations à la perception-conscience et participe ainsi au refoulement. Elle impose des déformations importantes aux contenus qui franchissent cette limite, comme dans le travail du rêve.
Pare-excitation	Fonction protectrice figurée à la surface de l'appareil psychique, limitant l'irruption d'excitations externes trop intenses ; l'environnement soutient cette protection au début de la vie.
Traumatisme psychique	Dans le cadre du cours, expérience d'excitation débordant les capacités de maîtrise et de traitement psychique, pensée comme une effraction du pare-excitation. Ses effets ne se déduisent pas du seul événement.
Ça	Instance constituant le pôle pulsionnel et le réservoir de l'énergie pulsionnelle de la personnalité. Ses contenus sont inconscients et son extrémité s'ouvre du côté somatique. Le support le décrit comme un ensemble de tendances contradictoires, cherchant satisfaction et ignorant les jugements de valeur, le bien, le mal et la morale.
Moi	Instance médiatrice chargée des intérêts de la totalité de la personne entre revendications du Ça, impératifs du Surmoi et contraintes de la réalité. Son autonomie reste fragile face à ces exigences. Le Moi est à la fois un appareil adaptatif se différenciant du Ça au contact de la réalité et une unité assurant stabilité et identité par les identifications. Il comporte une part consciente, recouvre largement le préconscient et possède une part inconsciente importante, notamment son pôle défensif mobilisé face à l'angoisse.
Surmoi	Instance présentée comme héritière du complexe d'Œdipe et issue de l'intériorisation des exigences et interdits parentaux, sociaux et culturels, notamment les interdits de l'inceste et du meurtre. Elle exerce trois fonctions : auto-observation critique, conscience morale et censure à l'égard du Moi, formation des idéaux. Le cours associe la culpabilité à la transgression des interdits et la honte à l'écart envers l'Idéal du Moi.
Idéal du Moi	Ensemble des idéaux et de l'image de ce que le sujet voudrait être ; l'écart à cet idéal peut mobiliser la honte dans la distinction faite à l'oral.
Culpabilité	Affect lié au sentiment d'avoir transgressé un interdit ou fait du mal à un autre, relié au Surmoi et au lien à l'objet dans le cours.
Honte	Affect touchant l'image et la valeur de soi, notamment l'écart entre ce que l'on est et son idéal ; l'oral la distingue de la culpabilité.
Point de vue économique	Lecture des processus psychiques selon les quantités d'excitation, leurs variations, leur circulation et leur répartition.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Principe de constance	Tendance de l'appareil psychique, dans la théorie, à maintenir les quantités d'excitation à un niveau aussi bas que possible.
Principe de plaisir	Principe selon lequel l'activité psychique évite le déplaisir et recherche le plaisir en réduisant au minimum la tension. Dans le modèle, l'augmentation des quantités d'excitation correspond au déplaisir et leur diminution au plaisir. Ce principe régit les phénomènes inconscients et le Ça ; il est modifié par le principe de réalité.
Principe de réalité	Principe régulateur qui modifie la recherche de plaisir : la satisfaction n'emprunte plus nécessairement la voie la plus courte mais accepte détours et ajournement en fonction du monde extérieur. Il se construit progressivement avec la confrontation à la réalité et le développement de l'attention, du jugement, de la mémoire et de la pensée. Il prévaut au niveau du Moi.
Processus primaire	Mode de fonctionnement caractéristique de l'inconscient, où l'énergie circule librement d'une représentation à l'autre, notamment par condensation et déplacement.
Processus secondaire	Mode de fonctionnement des systèmes préconscient et conscient, dans lequel l'énergie est liée à des représentations investies de manière plus stable et circule de façon contrôlée. Il permet l'ajournement de la satisfaction grâce à la pensée vigilante, l'attention, le jugement, le raisonnement et l'action contrôlée.
Libido	Énergie des pulsions sexuelles au sens élargi de la psychanalyse ; elle peut être investie dans le Moi, des objets, des représentations ou des activités.
Investissement libidinal	Attachement ou allocation d'énergie psychique à une représentation, un objet, une partie du corps ou une activité dans le modèle économique.
Libido narcissique	Part de l'investissement libidinal dirigée vers le Moi ; elle participe à l'image, à la valeur et au soin de soi.
Libido objectale	Part de l'investissement libidinal dirigée vers des objets extérieurs au Moi, notamment des personnes aimées.
Compulsion de répétition	Tendance inconsciente à répéter des expériences ou situations pénibles, qui dépasse une explication fondée sur la seule recherche de plaisir ; le cours l'évoque notamment à propos du traumatisme.
Point de vue dynamique	Lecture des phénomènes psychiques comme résultant du jeu et du conflit entre forces ou exigences opposées, particulièrement d'origine pulsionnelle.
Conflit psychique	Opposition d'exigences internes incompatibles, par exemple désir et interdit ou désir et défense ; il peut être manifeste ou latent et s'exprimer indirectement.
Dualisme pulsionnel	Construction théorique opposant deux groupes de pulsions ; le premier dualisme distingue autoconservation et sexualité, le second pulsions de vie et de mort.
Pulsions d'autoconservation	Pulsions orientées vers la préservation de l'individu et ses fonctions vitales, telles que nutrition, excrétion ou autoprotection dans le modèle.
Pulsions sexuelles	Pulsions recherchant un plaisir corporel qui dépasse la seule satisfaction des besoins ; le terme est plus large que les conduites génitales adultes.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Étayage	Appui initial des pulsions sexuelles sur les fonctions d'autoconservation, auxquelles elles empruntent source et objet avant de rechercher une prime de plaisir indépendante du besoin.
Pulsion partielle	Composante pulsionnelle à source et but locaux, fonctionnant initialement de façon relativement autonome avant l'organisation sous le primat génital.
Pulsions de vie · Éros	Dans le second dualisme, ensemble associant sexualité et autoconservation, orienté vers la liaison et la constitution d'unités plus grandes.
Pulsion de mort · Thanatos	Hypothèse du second dualisme d'une tendance à la réduction complète des tensions et au retour du vivant à l'inorganique. Dans le support, elle serait d'abord tournée vers l'intérieur et l'autodestruction, puis vers l'extérieur sous forme de pulsion d'agression. Elle est mise en lien avec répétition et sadomasochisme. C'est un concept métapsychologique ; elle est généralement pensée comme intriquée aux pulsions de vie.
Intrication pulsionnelle	Association des tendances de vie et de mort dans une même expression psychique ou conduite, plutôt que leur présence indépendante et pure.
Névrose de destinée	Expression historique employée à l'oral pour décrire des répétitions de situations relationnelles ou de vie pénibles, apparemment subies comme un destin, et rapprochées de la compulsion de répétition. Elle ne permet pas d'attribuer au sujet la responsabilité des violences qu'il subit.
Carence du préconscient	Hypothèse psychanalytique évoquée à l'oral lorsque des contenus trop chargés d'affects deviennent difficiles à mobiliser et à penser. L'action peut alors court-circuiter l'élaboration. Cette lecture ne constitue pas un critère diagnostique suffisant d'addiction, de trouble alimentaire ou de passage à l'acte.

Développement, objets et angoisses

46 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Sexualité infantile	Ensemble d'activités précoces procurant un plaisir corporel dépassant la satisfaction du besoin, avec zones érogènes, étayage, pulsions partielles et auto-érotisme ; elle n'est pas une sexualité génitale adulte.
Auto-érotisme	Mode de satisfaction pulsionnelle trouvé dans le corps propre, initialement au niveau de zones partielles, sans recours nécessaire à un objet extérieur.
Narcissisme	Investissement libidinal du Moi et de l'image unifiée de son corps comme objet d'amour. Dans le cours, le sujet se prend lui-même comme objet ; la notion n'a pas d'emblée une connotation négative. Elle concerne identifications, idéaux, estime de soi et image de soi. L'équilibre des investissements varie entre libido narcissique et libido d'objet.
Amour d'objet	Investissement affectif et libidinal d'un autre objet que le Moi, notamment une personne reconnue comme extérieure et distincte.
Objet partiel	Partie d'une personne ou élément investi psychiquement, par exemple le sein dans le stade oral, plutôt que la personne reconnue dans sa totalité.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Objet total ou global	Personne investie et reconnue comme une totalité distincte, pouvant réunir des qualités appréciées et frustrantes.
Objet interne	Représentation psychiquement intériorisée d'un objet ou du lien à celui-ci ; elle permet notamment de conserver un sentiment du lien en son absence.
Objet externe	Objet ou personne existant à l'extérieur du sujet, avec lequel il entre réellement en relation ; il se distingue de sa représentation interne.
Incorporation	But pulsionnel consistant à faire entrer en soi un objet de manière réelle ou fantasmatique, particulièrement important dans la description du stade oral.
Stade oral	Repère développemental, de la naissance au sevrage mais se prolongeant au-delà, où prédomine la zone buccale comme source de plaisir. Le support étend cette source au carrefour aérodigestif, à la phonation, aux organes des sens et à la peau comme zones d'échange avec l'entourage. L'objet premier est le sein ou son substitut, objet partiel ; le but est l'incorporation réelle ou fantasmatique. Il comprend un temps oral primitif de succion et un temps sadique-oral de morsure et d'ambivalence.
Sous-stade oral primitif	Temps de l'oralité dominé par succion et aspiration, avec une faible différenciation entre sujet et objet dans le modèle.
Sous-stade sadique-oral	Temps de l'oralité dominé par la morsure et une incorporation pouvant être vécue fantasmatiquement comme destruction, avec émergence de l'ambivalence.
Sevrage	Arrêt ou modification de l'alimentation au sein, mobilisant dans la lecture du cours des enjeux de séparation et de satisfaction orale, sans définir un âge universel de fin du stade oral.
Stade anal	Repère surtout situé dans les deuxième et troisième années, se prolongeant au-delà et lié aux acquisitions de maîtrise : marche, parole, pensée et contrôle sphinctérien. Sa source est la zone anale et intestinale d'excrétion, son objet les fèces vécues comme partie du corps propre, ses buts l'expulsion et la rétention. Dans le modèle, il soutient les distinctions dedans-dehors et Moi/non-Moi, et les échanges avec l'entourage, avec des équivalences symboliques entre fèces, argent et cadeau.
Phase expulsive	Sous-temps anal dominé par l'excrétion et l'expulsion. Le support lui associe une dimension auto-érotique, le rapport aux demandes parentales et une dimension sadique, figurée comme destruction de l'objet-fèces et agressivité envers l'entourage.
Phase rétentive	Sous-temps anal dominé par la rétention. Le support lui associe une dimension masochique du fait de retenir et une dimension sadique du fait de garder l'objet précieux demandé par les adultes ; cette opposition participe à l'émergence de l'ambivalence dans le modèle.
Ambivalence	Coexistence de sentiments ou tendances opposés envers un même objet, notamment amour et hostilité ; elle ne signifie pas simplement changer successivement d'avis.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Stade phallique	Repère à partir d'environ trois ans où commence une unification des pulsions partielles sous une prévalence génitale, avec curiosité pour les organes génitaux, la différence des sexes et les origines. Dans la conception freudienne exposée, le monisme phallique oppose présence et absence du pénis. Ce stade reste dit prégénital car le phallus est surtout investi comme puissance ou complétude et comme objet partiel possédé ou non. Il ouvre vers le complexe d'Œdipe et ses angoisses de castration. Cette théorie historique est discutée dans le cours oral.
Monisme phallique	Hypothèse freudienne selon laquelle l'enfant se représenterait d'abord une seule référence génitale, en opposant présence et absence du pénis ; le cours oral rappelle que cette conception est discutée.
Théories sexuelles infantiles	Explications élaborées par l'enfant pour donner sens aux origines, à la procréation et à la naissance, à partir de ses représentations et de son niveau de développement.
Complexe d'Œdipe	Ensemble de désirs amoureux et hostiles à l'égard des deux figures parentales, avec formes positive, négative et complète dans la théorie freudienne. Le support lui attribue un rôle nodal : dépassement de l'auto-érotisme, orientation vers des objets extérieurs globaux, entiers et sexués, triangulation, genèse du Surmoi et de l'Idéal du Moi. Sa résolution implique renoncement à la possession des objets parentaux, intériorisation des interdits de l'inceste et du meurtre, identifications et perspective d'autres objets d'amour : passer de l'avoir à l'être comme.
Œdipe positif, négatif et complet	Forme positive : attirance pour le parent de sexe opposé et rivalité envers celui de même sexe ; forme négative : distribution inverse ; forme complète : coexistence et articulation des deux dans le modèle.
Triangulation	Accès à une relation où un tiers a une place et où l'objet aimé peut investir un autre lien ; elle implique de sortir d'une exclusivité à deux.
Période de latence	Période située approximativement de six-sept ans à la puberté, après l'Œdipe, décrite comme un repos seulement apparent du fait du refoulement. Ce n'est pas un stade car elle n'est pas un nouveau moment d'organisation autour d'une zone érogène. Les interdits, l'immaturité et les contraintes externes contribuent à l'inhibition du but sexuel ; la libido est réorientée vers les apprentissages, les activités, les liens tendres avec les parents et de nouveaux objets sociaux.
Amnésie infantile	Rareté ou absence de souvenirs conscients des premières années de vie, reliée au refoulement dans le cadre explicatif du cours.
Primat du génital	Organisation dans laquelle les pulsions partielles sont davantage coordonnées sous la prévalence génitale ; le cours la situe dans le développement psychosexuel et ses remaniements pubertaires.
Fixation	Maintien privilégié d'un investissement ou d'un mode de satisfaction lié à un temps antérieur du développement, auquel une régression peut ensuite reconduire dans la lecture psychanalytique.
Angoisse	Peur sans objet, ou sans objet clairement défini, traduisant dans le cours la détresse de l'appareil psychique face à des menaces internes et pouvant mobiliser ses défenses.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Signal d'angoisse	Forme atténuée d'angoisse jouant un rôle d'alarme pour le Moi et déclenchant des opérations défensives dans la seconde théorie freudienne.
Angoisse automatique	Réaction de débordement face à un afflux d'excitations internes ou externes que le sujet ne peut maîtriser ; elle se distingue du signal d'alarme atténué.
Angoisses de morcellement	Angoisses massives et archaïques de destruction, d'anéantissement, d'annihilation, de dévoration, de mort psychique ou par éclatement, se traduisant par la sensation que le corps part en morceaux ou que l'identité vole en éclats.
Angoisses de perte d'objet	Angoisses liées à la séparation ou à la perte, réelle, anticipée ou fantasmatique, d'un objet d'amour. Le cours les rapproche des angoisses d'abandon et de séparation, particulièrement décrites dans les états-limites.
Angoisses de castration	Angoisses de pertes symboliques touchant le sentiment de puissance ou de complétude et pouvant atteindre fantasmatiquement féminité, virilité, capacités intellectuelles ou physiques, autonomie et indépendance.
Relation d'objet	Manière dont un sujet investit ses objets et entre en relation avec eux, en fonction de son organisation et des modalités de son fonctionnement psychique.
Relation anaclitique	Relation dans laquelle le sujet s'appuie fortement sur un objet extérieur pour soutenir son équilibre et son Moi, avec une crainte importante de le perdre.
Structure psychique	Organisation relativement stable du fonctionnement de la personnalité dans la théorie psychanalytique, qui oriente les modalités de conflit, de défense et de décompensation.
Décompensation	Rupture d'un équilibre psychique antérieurement maintenu, avec apparition ou accentuation de manifestations psychopathologiques selon les fragilités de l'organisation.
Névrose	Notion clinique et théorique historique désignant dans le support une maladie mentale dont le sujet reste douloureusement conscient. Elle peut entraîner des troubles durables de la personnalité, sans altérer profondément les fonctions essentielles. Le support la décrit comme fonctionnelle, sans lésion, et caractérisée par des conflits intrapsychiques, notamment dans l'hystérie, la névrose phobique et la névrose obsessionnelle. L'oral insiste sur le maintien global du contact avec la réalité. Cette définition historique ne constitue pas l'équivalent d'une catégorie diagnostique contemporaine unique.
Psychose	Notion regroupant dans le cadre du cours des organisations et tableaux où le rapport à la réalité peut être profondément altéré ; elle ne se définit pas par un signe isolé.
États-limites	Organisations décrites par Bergeret comme des astructurations entre les grandes structures, avec enjeux narcissiques, dépendance à l'objet et angoisses de perte ; ce modèle ne se confond pas automatiquement avec une catégorie du DSM.
Perversion	Notion historique de la psychopathologie psychanalytique, distincte de l'usage courant d'insulte ; le cours insiste sur la coexistence de reconnaissance et de déni de la loi ou de la castration dans le clivage dit pervers.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Puberté et remaniement psychosexuel	Dans le modèle du cours, poussée pulsionnelle et modifications corporelles s'accompagnent d'un remaniement identificatoire et d'une réactivation des enjeux œdipiens. La capacité génitale donne une portée nouvelle aux fantasmes incestueux, contre lesquels le sujet se défend, et sollicite la prise de distance avec les objets parentaux au profit d'autres investissements.
Première théorie freudienne de l'angoisse	Le refoulement produit l'angoisse : lorsque la pulsion ne peut être satisfaite, la représentation est refoulée et la charge ou quantum d'affect est transformé en angoisse. C'est la première articulation causale exposée dans le support.
Seconde théorie freudienne de l'angoisse	L'angoisse provoque les défenses, notamment le refoulement. Un signal de déplaisir, reproduction atténuée d'une ancienne réaction traumatique, mobilise le Moi face aux exigences pulsionnelles ; la perte ou menace de perte de l'objet joue souvent un rôle. Ce signal se distingue du débordement de l'angoisse automatique.
Deuil et travail de deuil	Réaction à la perte d'un objet d'amour et travail de remaniement psychique de cet investissement. Dans l'exemple oral, le sujet reprend les traces de la relation et peut conserver un lien intérieur à l'objet par introjection. La souffrance n'est pas automatiquement pathologique ; contexte, intensité, durée et retentissement sont à examiner.
Stade du miroir	Repère évoqué à l'oral pour penser la reconnaissance de sa propre image et la constitution d'un sentiment d'unité du corps et du Moi. Il sert ici à comprendre le pôle identitaire, sans constituer un test diagnostique ni une explication suffisante d'une pathologie.

Chaque mécanisme de défense et la relation de soin

32 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Mécanisme de défense	Opération par laquelle le Moi se protège d'une menace ou d'un conflit susceptible de susciter une angoisse et d'atteindre l'intégrité psychique. Ces opérations sont inconscientes dans la liste du cours, sauf la mise à l'écart volontaire.
Refoulement	Opération inconsciente repoussant ou maintenant hors de la conscience des représentations conflictuelles qui restent actives. Leur retour transformé peut participer au rêve, au lapsus ou au symptôme.
Retour du refoulé	Réapparition indirecte et transformée de contenus maintenus dans l'inconscient, notamment lorsque le refoulement ne suffit plus à les contenir.
Déplacement	Transfert de l'accent ou de l'intensité affective d'une représentation vers une autre, initialement moins importante, par des liens associatifs ; le conflit est ainsi déplacé vers un autre contenu.
Isolation	Séparation d'une représentation et de l'affect qui lui est associé, ou déconnexion de pensées et conduites normalement liées ; le contenu peut rester conscient mais apparaître froid ou indifférent.
Annulation rétroactive	Tentative inconsciente de rendre non advenus une pensée, une parole ou un geste au moyen d'une autre pensée ou conduite de sens opposé ; elle relève d'une logique de pensée magique.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Formation réactionnelle	Adoption d'une attitude ou d'un trait opposé à un désir refoulé, souvent de façon rigide, forcée ou excessive ; le cours cite notamment une pudeur très accentuée contre une tendance exhibitionniste.
Dénégation	Refus de reconnaître comme sien un désir, une pensée ou un sentiment venant d'être formulé et jusque-là refoulé. Le contenu atteint l'expression, mais le sujet en refuse l'appartenance.
Déni	Refus inconscient de reconnaître la réalité d'une perception vécue comme trop dangereuse, traumatisante ou douloureuse pour le Moi ; il ne se confond pas avec une contestation volontaire ni un simple doute.
Projection	Attribution au dehors, à une personne ou une chose, de pensées, affects, désirs ou qualités que le sujet méconnaît ou refuse de reconnaître en lui-même.
Clivage du Moi	Coexistence dans le Moi de deux attitudes psychiques contradictoires, par exemple reconnaissance et déni de la réalité, qui persistent sans s'influencer et sans compromis.
Clivage de l'objet	Séparation de l'objet en un pôle entièrement bon et un pôle entièrement mauvais, difficilement réunis dans une représentation ambivalente. Le bon objet est gratifiant, idéalisé et recherché ; le mauvais est frustrant, dévalorisé et attaqué. L'oral décrit comment cette opposition peut être projetée sur différents membres d'une équipe.
Renversement en son contraire	Transformation du but pulsionnel en son contraire : activité en passivité, amour en haine, voyeurisme en exhibitionnisme, sadisme en masochisme ou inversement. Il concerne l'orientation de la tendance et se distingue de la formation réactionnelle qui porte notamment sur une attitude ou un trait de caractère opposé au désir refoulé.
Retournement contre soi	Détournement vers soi d'une agressivité qui ne peut être reconnue ou adressée à l'objet extérieur ; le cours le relie notamment à la culpabilité et aux conduites autopunitives.
Introjection	Inclusion fantasmatique dans le psychisme d'un objet, d'une partie de l'objet ou du lien avec lui. Elle permet notamment de garder intérieurement les traces d'une relation malgré l'absence ou la perte.
Identification	Assimilation inconsciente d'un aspect, d'une propriété ou d'un attribut d'autrui, conduisant le sujet à se transformer en partie ou en totalité sur ce modèle ; les identifications participent à la construction de la personnalité.
Identification à l'agresseur	Forme d'identification où un sujet confronté à un danger extérieur s'identifie à son agresseur, soit en reprenant l'agression, soit en l'imitant physiquement ou moralement, soit en adoptant des symboles de puissance qui le caractérisent. Ce processus défensif ne constitue ni un consentement à la violence ni un choix délibéré de la subir.
Idéalisation	Élévation des qualités et de la valeur d'un objet à un degré de perfection, pouvant servir à se défendre contre la haine et l'ambivalence dans la lecture du cours.
Régression	Retour plus ou moins organisé et transitoire à des modes antérieurs de pensée, de conduite ou de relation face à une angoisse ou une frustration ; elle peut apparaître dans la maladie.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Activisme	Recours à l'action pour gérer un conflit ou une situation traumatique à la place de la réflexion et du vécu des affects ; l'agitation peut ainsi éviter de penser ce qui angoisse.
Rationalisation	Justification apparemment logique mais artificielle de jugements, sentiments ou conduites, masquant à l'insu du sujet leurs motifs inconscients.
Intellectualisation	Recours privilégié à l'abstraction et à la généralisation pour se tenir à distance d'une situation dont l'affect serait trop angoissant ; elle se distingue d'une recherche volontaire d'informations.
Sublimation	Le support regroupe deux devenirs de la pulsion : d'une part, inhibition du but sexuel en conservant le même objet, avec transformation du désir en tendresse, amitié ou camaraderie ; d'autre part, dérivation de la libido vers des activités artistiques, intellectuelles ou morales socialement valorisées, avec changement de but ou d'objet et sans recours au refoulement. Il faut distinguer ces deux descriptions et ne pas confondre sublimation et refoulement.
Humour	Dans la liste des défenses, manière de présenter sa propre situation pénible ou traumatisante sous un angle plaisant, insolite ou ironique ; le cours insiste sur l'humour appliqué à soi.
Altruisme	Dans son emploi défensif, dévouement à autrui permettant au sujet d'échapper à un conflit psychique ; ce sens ne résume pas toutes les motivations d'une aide.
Mise à l'écart	Rejet volontaire, hors du champ actuel de la conscience, de problèmes, désirs, sentiments ou expériences qui tourmentent. Le cours la distingue comme consciente, à la différence du refoulement.
Transfert	Déplacement d'affects d'un objet du passé vers un objet du présent selon une analogie ou association le plus souvent inconsciente, réactualisant des attentes et modalités relationnelles antérieures.
Transfert positif / négatif	Polarités affectives du transfert : attachement, confiance ou idéalisation d'une part ; hostilité, crainte ou rejet d'autre part. Elles peuvent coexister et se modifier dans la relation.
Contre-transfert	Réactions psychiques du soignant engagées dans la rencontre avec le patient et ses mouvements transférentiels ; leur repérage soutient la réflexion sur la relation. Le terme est annoncé, sans développement détaillé, dans le support.
Résistance	Dans le contexte psychanalytique, processus faisant obstacle à l'accès ou au travail de certains contenus psychiques ; le transfert peut servir de résistance tout en constituant un levier thérapeutique.
Clivage institutionnel	Opposition entre groupes de professionnels pouvant prolonger dans l'équipe la division des objets en bons et mauvais vécue par le patient ; l'oral en fait un enjeu de réflexion collective.
Stratégies de coping	Manières de faire face à une situation stressante. L'oral distingue notamment la recherche volontaire d'informations pour réduire le stress de l'intellectualisation défensive, où la fonction d'éloignement de l'affect échappe au sujet.

Définitions et mots-clés — suite

Sémiologie, diagnostics et classifications

67 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Sémiologie psychiatrique	Étude et recueil des manifestations psychiques, en distinguant symptômes rapportés, signes observables et syndromes ; le terme séméiologie est aussi employé.
Symptôme	Au sens sémiologique précis, manifestation subjective d'un processus pathologique, ressentie ou décrite par le patient, à distinguer du signe clinique observé. Dans l'abord de la rencontre clinique, le support l'emploie aussi au sens plus large de signal d'alerte : changement émotionnel, cognitif ou comportemental tranchant avec le fonctionnement habituel, parfois repéré d'abord par l'entourage. Dans la lecture psychanalytique, certains symptômes sont compris comme formations de compromis entre désir et défense, dotées d'un sens et d'une fonction pour le sujet.
Signe clinique	Manifestation repérable par l'observation du clinicien, à distinguer du vécu subjectif rapporté ; son interprétation dépend du contexte et de son association à d'autres manifestations.
Syndrome	Association de signes et symptômes formant un ensemble clinique plus ou moins spécifique, susceptible d'orienter vers des hypothèses diagnostiques.
Signifiant / signifié	Dans la présentation sémiologique du support, le signifiant est la forme matérielle d'un signe ; le signifié est son contenu ou sa signification.
Nosographie	Description et organisation des maladies ou troubles en ensembles permettant leur classement et leur communication clinique.
Nosologie	Étude et organisation conceptuelle des maladies, de leurs catégories et de leurs relations ; l'oral la rattache notamment à la réflexion sur leurs causes.
Recueil sémiologique	Étape de collecte et de discrimination de ce que le patient décrit et de ce qui est observé, avant l'élaboration du diagnostic.
Diagnostic	Démarche et conclusion consistant à reconnaître un trouble à partir d'un ensemble de manifestations, de leur organisation, de leur contexte et de critères pertinents.
Hypothèse étiopathogénique	Proposition concernant les causes et mécanismes par lesquels un trouble s'est constitué et se maintient ; elle doit être distinguée d'un fait directement observé.
Diagnostic différentiel	Raisonnement distinguant plusieurs causes ou troubles susceptibles d'expliquer des manifestations proches, notamment une autre affection médicale ou l'effet d'une substance.
Bénéfice primaire	Dans le modèle psychanalytique, apaisement de l'angoisse ou diminution de l'intensité d'un conflit interne rendu possible par la formation du symptôme.
Bénéfice secondaire	Avantage conscient ou inconscient qu'un sujet peut tirer de sa pathologie psychique ou somatique ou de ses conséquences. Il est distinct de l'apaisement interne du conflit, appelé bénéfice primaire. Sa présence ne prouve pas une simulation ni l'absence de souffrance.
Symptôme labile	Manifestation changeante ou susceptible de se modifier rapidement ; le cours insiste sur cette labilité chez l'enfant en développement.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Classification	Mise en ordre de phénomènes dans un système de classes partageant des caractéristiques ; elle remplit des fonctions de systématisation et d'aide au diagnostic.
Systématisation	Organisation ordonnée d'une multiplicité de manifestations afin de pouvoir les décrire, les comparer et les penser plus facilement.
Classification catégorielle	Classement reposant sur la présence ou l'absence de critères permettant l'inclusion dans une catégorie définie.
Classification dimensionnelle	Évaluation de l'intensité ou de la fréquence d'une ou plusieurs dimensions, sans que leur mesure constitue automatiquement un diagnostic catégoriel.
Classification typologique	Description des troubles par types ou configurations de traits associés à des syndromes. L'appartenance repose sur certains traits essentiels, sans exiger tous les traits possibles. Le profil peut être établi à partir de l'observation et de l'expérience cliniques, éventuellement standardisées, ou par des méthodes statistiques ; il associe caractéristiques et intensité.
Validité externe	Adéquation de la classification avec la réalité clinique qu'elle cherche à représenter dans la présentation du cours.
Validité interne / cohérence	Cohérence des règles et des catégories du système permettant un raisonnement non contradictoire ; elle n'interdit pas l'existence de troubles associés.
Fidélité temporelle	Stabilité du résultat lorsqu'une même situation clinique inchangée est évaluée à différents moments avec le même système.
Fidélité inter-juges	Accord entre plusieurs évaluateurs utilisant le même système à partir d'une même situation clinique.
Sensibilité	Capacité de repérage des situations qui relèvent du trouble recherché ; le support l'évoque plus largement avec la capacité de différenciation des tableaux et de leurs évolutions.
Faux négatif	Situation où un trouble présent n'est pas repéré par la démarche de classification ou d'évaluation utilisée.
Faux positif	Situation où l'évaluation conclut à un trouble alors qu'il n'est pas présent dans les conditions recherchées.
Comorbidité	Présence associée de plusieurs troubles chez une même personne ; elle justifie de rechercher ce qui accompagne ou reste masqué derrière la plainte principale.
Épisode dépressif caractérisé · EDC	Ensemble d'au moins cinq des neuf manifestations décrites dans l'exemple du support, sur une même période d'au moins deux semaines, avec humeur dépressive ou perte d'intérêt/plaisir, changement et retentissement significatifs ; les exclusions doivent aussi être examinées.
Anhédonie	Diminution ou perte de la capacité à éprouver de l'intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement investies ; elle constitue un des deux symptômes centraux de l'exemple d'EDC.
Ralentissement psychomoteur	Diminution observable de l'activité motrice et du rythme psychique ; dans l'exemple diagnostique, il ne se limite pas au seul ressenti intérieur de lenteur.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Hypersomnie / insomnie	Augmentation excessive du sommeil d'une part ; difficulté de sommeil d'autre part. Elles font partie des manifestations à considérer dans l'exemple dépressif, sans être spécifiques à elles seules.
Manie / hypomanie	États d'élévation ou d'irritabilité de l'humeur et d'activation, d'intensité et de retentissement différents. Le support les cite surtout comme antécédents à rechercher pour distinguer le trouble dépressif unipolaire d'un trouble bipolaire ; leurs critères complets ne sont pas détaillés ici.
Rémission partielle	Amélioration d'un trouble avec persistance de certaines manifestations ou de critères résiduels ; elle se distingue de la rémission complète.
Rémission complète	Disparition des manifestations définissant l'épisode considéré ; elle ne signifie pas automatiquement disparition de toute vulnérabilité ou arrêt d'un suivi.
Rechute	Réapparition ou aggravation d'un trouble après une amélioration ; elle doit être appréciée dans l'évolution clinique.
Diagnostic provisoire	Hypothèse diagnostique retenue en attente d'informations ou d'une observation évolutive suffisantes, plutôt qu'une conclusion présentée comme définitive.
Diagnostic non spécifié	Catégorie employée lorsqu'un tableau répond aux critères généraux d'une classe sans satisfaire ceux d'un trouble spécifique, ou lorsqu'un regroupement non inclus dans la classification provoque une souffrance ou une déficience significative. Le support cite aussi l'étiologie incertaine et des informations manquantes, incohérentes ou contradictoires. Ce terme ne signifie ni absence de trouble ni certitude sur sa cause.
Diagnostic de rétablissement	Évaluation des perspectives d'amélioration et de retour à une vie ordinaire en fonction des ressources et possibilités de la personne, en complément du nom du trouble.
DSM	Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'American Psychiatric Association ; le cours présente le DSM-5 comme descriptif et principalement catégoriel, avec critères et spécifications de sévérité et d'évolution.
CIM	Classification internationale des maladies portée par l'Organisation mondiale de la santé, couvrant maladies et problèmes de santé ; le support compare sa démarche clinique à celle du DSM.
CFTMEA	Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, soulignant des repères développementaux, dynamiques et structuraux, ainsi que des dimensions catégorielles et dimensionnelles.
APA / OMS	APA : American Psychiatric Association, organisme éditant le DSM. OMS : Organisation mondiale de la santé, responsable de la CIM dans la présentation du cours.
Mortalité / morbidité	La mortalité concerne les décès dans une population ; la morbidité concerne la présence ou la fréquence des maladies. Le cours les relie à l'histoire et aux usages de la CIM.
Modèle processuel	Modèle centré sur les processus psychiques participant à la dynamique des troubles, plutôt que seulement sur leur classement en catégories.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Processus transdiagnostique	Mécanisme susceptible d'intervenir dans plusieurs troubles ou catégories diagnostiques ; son étude peut relier des tableaux différents.
Modèle en réseau de symptômes	Modèle expliquant un trouble par des relations complexes et des interactions entre symptômes, sans supposer nécessairement une cause morbide sous-jacente unique.
Névroses actuelles / de transfert	Distinction historique freudienne : les premières sont rapportées à des facteurs actuels ; les secondes sont abordées à partir de conflits et de leur réactualisation transférentielle. Ces groupes ne sont pas des équivalents directs des diagnostics contemporains.
Névrose d'angoisse	Catégorie historique de névrose actuelle centrée sur des manifestations anxieuses ; les rapprochements proposés à l'oral avec les troubles anxieux sont des repères, pas une équivalence nosographique exacte.
Neurasthénie	Catégorie historique citée parmi les névroses actuelles, associant notamment fatigue et plaintes nerveuses ; ses critères ne sont pas développés dans ce support.
Hypocondrie	Préoccupation anxieuse concernant la santé et la possibilité d'être malade, citée dans la classification historique ; cette mention ne suffit pas à définir tous les critères d'un diagnostic contemporain.
Névrose obsessionnelle	Catégorie historique marquée par des pensées contraignantes, conflits et défenses notamment d'isolation et d'annulation ; elle ne se superpose pas automatiquement à tout trouble obsessionnel-compulsif.
Névrose phobique	Catégorie historique où une crainte est attachée à un objet ou une situation et peut conduire à l'évitement ; elle est aussi appelée hystérie d'angoisse dans la classification présentée.
Schizophrénie	Trouble cité dans les psychoses et rattaché à la dissociation dans la tradition française du cours ; l'oral insiste sur la désorganisation de la pensée et des associations, et non sur une double personnalité. Le support n'en expose pas tous les critères diagnostiques.
Paranoïa / psychose paranoïaque	Notions historiques de psychose non dissociative du tableau français, associées dans l'oral à un délire et à une lecture projective ; leurs critères complets ne sont pas exposés dans ce cours introductif.
Mélancolie / manie et PMD	Termes de la classification historique regroupés sous psychose maniaco-dépressive. L'oral rapproche la PMD des troubles bipolaires et décrit la mélancolie comme une dépression particulièrement grave ; ce rapprochement ne remplace pas les critères diagnostiques.
Bouffée délirante aiguë · BDA	Terme de la tradition française désignant un tableau psychotique aigu, d'apparition rapide, dont l'évolution doit être observée. Un épisode isolé ne permet pas de conclure d'emblée à une évolution chronique.
Dissociation psychiatrique	Dans la tradition française présentée, désorganisation des liens entre pensée, affect et comportement, illustrée surtout à l'oral par la rupture des associations. Elle ne signifie pas une double personnalité.
Barrage	Interruption brusque du cours de la pensée ou du discours, illustrée à l'oral comme une manifestation de la désorganisation des associations.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Fading	Effacement ou ralentissement progressif du cours de la pensée et du discours, distingué à l'oral du caractère abrupt du barrage.
Psychose hallucinatoire chronique · PHC	Catégorie historique française de psychose chronique non dissociative où les phénomènes hallucinatoires et l'automatisme mental occupent une place importante dans la présentation orale.
Automatisme mental	Ensemble de phénomènes vécus comme imposés ou échappant à la maîtrise du sujet, notamment autour de la pensée ; il est évoqué à l'oral à propos de la PHC sans description exhaustive.
Paraphrénies	Catégories historiques de psychoses chroniques non dissociatives, évoquées à l'oral par des productions délirantes imaginatives et fantastiques ; leurs critères ne sont pas détaillés dans le support.
Impulsion / compulsion	L'oral distingue une tendance impérieuse au passage à l'acte, pouvant court-circuiter la pensée, d'une conduite contraignante contre laquelle le sujet peut lutter anxieusement. Ces termes ne sont pas synonymes de pulsion.
Athéorique	Dans la présentation du DSM, intention de ne pas faire dépendre la description diagnostique d'une théorie causale particulière et de privilégier les critères cliniques et les données empiriques. L'oral rappelle que la construction d'une classification comporte néanmoins des choix.
Sévérité légère, moyenne ou sévère	Spécification de l'intensité d'un trouble. Le support décrit un niveau léger avec peu de symptômes au-delà du minimum requis et une altération mineure du fonctionnement ; un niveau sévère avec davantage de symptômes, des manifestations particulièrement intenses ou un retentissement marqué ; le niveau moyen est intermédiaire.
Antécédent / diagnostic principal	Un antécédent est un événement ou trouble de l'histoire clinique utile à l'évaluation actuelle. Le diagnostic principal désigne le trouble retenu comme principal dans la situation de consultation ; les troubles associés ne disparaissent pas pour autant. Le motif exprimé de consultation et le diagnostic principal sont à distinguer.
Transcodage	Mise en correspondance des codes de plusieurs classifications, notamment CFTMEA et CIM dans le support, pour faciliter les échanges, recherches et usages administratifs. Une correspondance de code n'implique pas une identité parfaite des concepts.

Vocabulaire clinique rencontré dans les exemples

19 notions à définir et à distinguer.

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Hallucination	Expérience perceptive vécue en l'absence d'un objet extérieur correspondant, évoquée notamment dans les exemples de voix ; sa signification doit être appréciée dans son contexte et ne définit pas seule un diagnostic.
Délire	Ensemble de convictions et d'interprétations marquant une altération du rapport à la réalité dans les tableaux psychotiques cités ; le contenu seul ne suffit pas à caractériser tout le fonctionnement d'une personne.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Dépersonnalisation	Expérience d'étrangeté concernant soi-même ou son identité, évoquée à l'oral pour illustrer le sentiment de ne plus se reconnaître ou de perdre son unité.
Reviviscence traumatique	Retour vécu comme actuel d'éléments d'une expérience traumatique, cité à l'oral avec les cauchemars ; le souvenir pénible peut s'imposer plutôt qu'être volontairement recherché.
Passage à l'acte	Recours à une action pouvant court-circuiter l'élaboration et l'expression psychiques d'un conflit ou d'un affect dans la lecture orale du cours ; les causes d'un acte ne se réduisent pas à cette seule hypothèse.
Anesthésie psychique	Sensation de ne plus éprouver d'émotions ou de se sentir intérieurement vide, décrite dans un exemple oral de souffrance dépressive très importante.
Angoisse de dévoration	Forme d'angoisse archaïque où le sujet redoute d'être absorbé ou détruit par l'objet ; elle figure dans la définition orale des angoisses de morcellement.
Astasie-abasie	Incapacité à se tenir debout et à marcher, illustrée dans le cas historique d'Élisabeth ; le terme décrit une difficulté et ne démontre pas, à lui seul, sa cause.
Aphonie	Perte de la voix ; elle fait partie des manifestations corporelles citées dans l'histoire de l'hystérie, sans que toute aphonie soit psychogène.
Aphasie	Trouble du langage affectant son expression ou sa compréhension ; elle est citée dans le récit d'Anna O. et dans les repères historiques sur Freud, sans fournir ici une classification neurologique.
Mutisme	Absence de parole dans une situation donnée ; il est cité parmi les manifestations historiques et demande une analyse de son contexte et de ses causes.
Parésie / paralysie	La parésie désigne une diminution de la force motrice ; la paralysie une perte du mouvement volontaire. Leur présence ne permet pas d'en déduire automatiquement une origine psychique.
Anesthésie corporelle	Perte ou diminution de sensibilité dans un territoire, citée parmi les symptômes historiques ; elle se distingue de l'anesthésie psychique qui concerne le ressenti affectif.
Algies / céphalées	Algies : douleurs ; céphalées : douleurs de la tête. Le support les mentionne parmi des expressions corporelles possibles, sans que ces termes déterminent leur étiologie.
Vaginisme	Contraction involontaire de la musculature à l'entrée du vagin rendant la pénétration difficile ou impossible ; le terme est cité dans la liste historique des manifestations corporelles, sans développement thérapeutique dans ce support.
Psyché-soma	Expression soulignant les liens entre vie psychique et corps, notamment chez le jeune enfant dont les difficultés peuvent s'exprimer par des manifestations corporelles.
Énurésie	Émission involontaire d'urine, évoquée à l'oral comme une manifestation possible chez l'enfant ; l'âge, le développement, le contexte et les causes doivent être pris en compte avant d'en interpréter le sens.

Définitions et mots-clés — suite

Notion	Définition complète dans le cadre du cours
Égodystonique / égosyntonique	Un vécu égodystonique est ressenti comme étranger ou en désaccord avec soi ; un vécu égosyntonique est en accord avec soi. Ces mots décrivent le rapport subjectif à un vécu et ne suffisent pas à conclure à une pathologie.
Morbidité / indice morbide	Le premier terme renvoie aux maladies dans une population ; l'emploi de « morbide » dans la définition du champ renvoie à ce qui concerne la maladie, sans constituer à lui seul un critère diagnostique.